

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 1 de 76

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO

**Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario, CESFAM Dr.
Orlando Leyton A., Peralillo**

Elaborado por: T.M. Juan Contreras Sandoval	Revisado por: TM. Pia Galvez Leyton	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas Espinoza
Unidad: Laboratorio clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo.	Unidad: D.T. Laboratorio clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo.	Unidad: Director CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo.
Fecha: 13-07-2026	Fecha: 21-07-2026	Fecha: 27-07-2026
Firma: 	Firma:  Pia Gálvez Leyton Rut: 12.780.991-7 Tecnóloga Médica	Firma:  

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 2 de 76

I. INTRODUCCIÓN.

El Laboratorio Clínico desempeña una función esencial en el análisis físico, químico y biológico de diversos componentes y productos del cuerpo humano. Los resultados obtenidos a través de estos análisis son herramientas indispensables para el **apoyo diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento** de las diversas patologías, contribuyendo directamente al cuidado de la salud de la población.

En el contexto de un centro de salud familiar (APS), la toma de muestras; que incluye la recolección de sangre, orina, deposiciones y secreciones; es una de las prestaciones fundamentales disponibles en la canasta de servicios. Sin embargo, la calidad del producto final, es decir, el resultado del examen no depende exclusivamente de un procedimiento analítico correcto, sino de manera crítica de una **toma de muestra adecuada**.

Este manual se enfoca primordialmente en la **etapa preanalítica**, la cual comprende desde la solicitud del examen y la preparación del paciente hasta la recolección, el manejo y el transporte de las muestras. Se reconoce que esta fase es uno de los principales puntos críticos donde pueden ocurrir errores que alteren los resultados, por lo que es competencia del personal de los centros de salud proveer muestras que cumplan estrictamente con las condiciones técnicas para su procesamiento.

El **objetivo principal** de este documento es estandarizar los procedimientos y actividades de la etapa preanalítica en el CESFAM y sus unidades asociadas. Al normalizar criterios sobre la identificación correcta del paciente, el uso de materiales adecuados, la rotulación precisa y el mantenimiento de la cadena de frío, se busca asegurar resultados de calidad y oportunos.

En última instancia, este manual pretende ser una herramienta de consulta y apoyo técnico para el personal clínico, con el fin de **garantizar la seguridad del paciente y**

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 3 de 76

de todas las personas involucradas en el proceso, permitiendo que las prestaciones brindadas en la atención primaria sean seguras, éticas y de excelencia.

II. OBJETIVOS.

a. OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procedimientos y actividades de la etapa preanalítica de los exámenes que se procesan en el laboratorio, asegurando resultados de calidad, confiables y oportunos, contribuyendo directamente a la seguridad del paciente y de todo el personal involucrado en los procesos de obtención, manejo y transporte de las muestras.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- **Definir los requisitos técnicos y administrativos** para el correcto llenado de la solicitud de exámenes y establecer con claridad los **criterios de aceptación y rechazo** de las muestras, asegurando la trazabilidad y disminuyendo la probabilidad de errores antes del análisis.
- **Describir los procedimientos operativos estandarizados** para la obtención, rotulación, conservación y transporte de las distintas muestras biológicas, garantizando la **estabilidad de los analitos** y el cumplimiento de las condiciones ambientales requeridas para cada examen.
- **Proporcionar una herramienta de consulta y apoyo técnico** que normalice las instrucciones de preparación del paciente y las **medidas de bioseguridad** necesarias, velando por la integridad física de los usuarios y del personal de salud durante todo el proceso.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 4 de 76

III. ALCANCE

Este manual aplica a todo el personal que trabaja o tiene acceso al laboratorio clínico, incluyendo técnicos, profesionales de salud, personal de limpieza, estudiantes en práctica y cualquier otra persona externa autorizada para entrar. También aplica para todos los procedimientos de toma de muestras realizados que estén vinculados al CESFAM Dr. Orlando Leyton A. (Postas, otras unidades del CESFAM, unidad de atención domiciliaria y otros) que serán analizadas en el laboratorio clínico institucional o derivadas a niveles superiores.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Jefatura de Laboratorio (DT): Gestionar lo necesario para la elaboración e implementación de los procedimientos descritos en el Manual, así como entregar orientaciones necesarias al personal del establecimiento en aspectos relacionados con la toma de muestras de exámenes.

Personal encargado de la toma de muestra (CESFAM, postas de Salud rural y Estación Médica Rural): Es responsable de dar instrucciones al paciente respecto de requisitos particulares definidos, corroborando en el momento de la toma de muestra que el paciente se haya preparado en forma correcta. De la ejecución de los procedimientos de toma de muestras descritos en el manual.

Personal Administrativo de S.O.M.E: Entregar indicaciones verbales y escritas de toma de muestra y entregar material necesario para la obtención de las mismas.

Conductores y/o estafetas: Traslado de muestras desde Postas de Salud Rurales a Laboratorio Clínico del CESFAM Orlando Leyton o desde laboratorio Clínico a Servicios donde se derivan muestras.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 5 de 76

Tecnólogo Médico: Controlar procesos de ingreso de orden al Sistema informático de laboratorio (SIL), preparación toma de muestra, toma de muestras, transporte de muestras, recepción de muestras, aceptación o rechazo.

V. DEFINICIONES

Ayuno estricto: No ingerir alimentos ni agua, al menos por 8 horas previo al examen.

ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Muestra: Parte representativa de distintos especímenes biológicos destinados a entregar información sobre el sistema biológico (sangre, orina, líquidos biológicos, otros).

Sangre entera: Muestra de sangre venosa, arterial o capilar sin cambio de concentraciones celulares, ni extracelulares in vivo.

Suero: Porción de sangre extracelular sin diluir obtenida después de completada la coagulación.

Plasma: Porción de sangre virtualmente libre de células con anticoagulante, obtenido post-centrifugación.

Coágulo: Masa sólida con todos los componentes sanguíneos y exuda suero.

Solicitud de Análisis: Documento normalizado que emite el profesional solicitante y es remitido al Laboratorio para la realización de los análisis.

Muestra primaria: recipiente que contiene la muestra biológica que será analizada.

Embalaje secundario: Contenedor que protege al recipiente primario, impermeable y con material absorbente, para uso en transporte.

Preanalítica: Fase que comprende desde la solicitud del examen hasta el ingreso de la muestra al laboratorio para su análisis.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 6 de 76

Criterio de rechazo: Condición en que una muestra no es aceptable para análisis por incumplir requisitos preanalíticos.

LIS: Sistema informático de laboratorio (Laboratory Information System).

Bioseguridad / precauciones estándar: Medidas universales para prevenir contaminación y proteger al personal frente a muestras biológicas.

Orina aislada: Muestra de orina con retención de 3 a 4 horas.

TRANS: Agrupa las identidades de género no tradicionales comprendiendo esta categoría a las personas transgénero, transexuales, travestis e intersex.

VI. DESARROLLO.

1. Etapa Preanalítica: Requisitos administrativos

1.1. Solicitud de exámenes

1.1.1. Modo Manual

Para cumplir con los requisitos de llenado, la solicitud de exámenes de laboratorio debe tener los siguientes datos:

- Identificación del paciente, es decir, **nombre completo** más **RUN**, en Extranjeros DNI, pasaporte y/o RUN provisorio, en lo ideal con letra clara. **(Dato crítico)**.
- Fecha de solicitud de examen
- Sexo
- Procedencia (programa de salud, posta o quien está derivando)
- Diagnóstico
- Fecha de nacimiento
- Exámenes solicitados
- Identificación del solicitante (médico o profesional que solicita) más firma

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 7 de 76

1.1.2. Modo virtual “Rayen”

Para la solicitud virtual de exámenes se ocupa el programa informático de RAYEN, que cuenta con fichas electrónica de paciente, además de trazabilidad de datos del paciente, lo cual beneficia en caso de extravío de la solicitud de examen física por parte del paciente.

1.2. Horario de atención de toma de muestra

El horario de atención de la **Toma muestra** en el laboratorio es de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 10:00 hrs. En cuanto a la **atención de laboratorio**, entrega de resultados, atención a público en general y otras dudas o consultas el horario de atención es de 7:30 a 16:30 horas. (Para más información respecto a el tiempo de espera en la entrega de resultados veasé **“Anexo 1. Tiempo de respuesta de exámenes”**)

1.3. Identificación del paciente

La identificación correcta del usuario es el primer paso crítico de la etapa preanalítica para garantizar la seguridad del paciente y evitar errores que puedan comprometer el diagnóstico y tratamiento. Este procedimiento debe realizarse obligatoriamente de forma presencial y previa a cualquier toma de muestra.

1.3.1 Verificación de Identidad

El personal encargado (administrativo, técnico o profesional) debe verificar la identidad del paciente. Se sugiere seguir estos pasos:

- **Solicitud de documento:** Solicitar siempre la **cédula de identidad vigente**, pasaporte o documento de identificación oficial. En caso de que el paciente no porte su cédula, se podrá verificar con documentos alternativos como el carné de FONASA o la ficha clínica.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 8 de 76

- **Verbalización por el usuario:** Se debe solicitar al paciente que **verbalice su nombre completo y número de RUN**. No se debe preguntar "¿Usted es el Sr. "X", sino dejar que el paciente se identifique activamente para evitar errores por asenso.
- **Concordancia:** Comprobar que los datos entregados por el paciente y los del documento de identidad coincidan exactamente con lo registrado en la **solicitud de exámenes** y, si aplica, en la ficha clínica electrónica (Rayen).

1.3.2. Identidad de Género (Nombre Social y legal)

En cumplimiento con la Ley N° 21.120 y la Circular N° 21/2012, el trato y registro de personas trans e intersex debe ajustarse a las siguientes normas:

- **Identificación verbal:** El trato y la identificación verbal del paciente durante toda la atención deben realizarse estrictamente por su **nombre social**.
- **Registro administrativo:** En los formularios, registros de atención y etiquetas, se debe consignar en primer lugar el **nombre legal** (que figura en su cédula de identidad) y, a continuación, el **nombre social entre paréntesis**.
- **Rotulación de muestras:** Las muestras biológicas deben rotularse siempre con el nombre legal para asegurar la trazabilidad legal y técnica en el sistema informático del laboratorio.

1.3.3. Verificación Frente al Usuario y Rotulación

- **Momento de la identificación:** La identidad debe ser confirmada nuevamente por el flebotomista en el box de atención, justo antes de iniciar la punción o recibir el espécimen.
- **Rotulación en presencia del paciente:** Todos los tubos y contenedores de muestras deben ser **rotulados o etiquetados inmediatamente después de la**

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 9 de 76

extracción, siempre frente al paciente y antes de que este abandone el box de toma de muestras.

1.3.4. Casos Especiales

- **Recién nacidos y lactantes:** La identificación se realiza verificando los datos con la madre o cuidador (nombre completo y RUN), o los datos de la madre en caso de que el recién nacido aún no cuente con registro.
- **Pacientes con compromiso de conciencia o dificultad de comunicación:** Si el paciente no puede confirmar su identidad, esta debe ser verificada a través de un familiar o acompañante, el brazalete de identificación institucional o la ficha clínica, dejando constancia de esta situación en la solicitud de examen.

1.4. Instrucciones de preparación del paciente

Para asegurar que los resultados de los análisis reflejen fielmente el estado clínico del usuario, es imperativo que el personal administrativo y clínico entregue **instrucciones claras, verbales y por escrito (véase, “Anexo 2: Instrucciones y preparación de pacientes”)**, sobre los requisitos previos a la toma de muestra. El cumplimiento de estas condiciones es responsabilidad compartida entre el equipo de salud y el paciente.

1.4.1. Requisitos de Ayuno

El ayuno es necesario para evitar la interferencia de nutrientes en las mediciones químicas y biológicas de la sangre.

- **Ayuno Adulto Estándar:** Generalmente comprende un periodo de **8 a 12 horas** sin ingerir alimentos sólidos ni líquidos (excepto agua). Durante este tiempo no se debe beber alcohol ni fumar.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 10 de 76

- **Ayuno Pediátrico:** En lactantes menores de 2 años se requiere un ayuno de **3 a 4 horas**; en niños de 3 a 6 años, el ayuno debe ser de **6 horas** y en mayores de 8 años, entre **8 a 10 horas**.
- **Ayuno Específico por Examen:**
 - **Perfil Lipídico (Triglicéridos):** Requiere un ayuno estricto de **12 horas**.

1.4.2. Dietas, hábitos, manejo de medicamentos y otras restricciones que pueden alterar resultados de laboratorio.

Ciertos exámenes requieren una modificación en la ingesta de alimentos y hábitos días antes del procedimiento, así como también, la toma de medicamentos puede alterar significativamente algunos analitos, por lo que se deben seguir las siguientes directrices y se debe instruir al paciente:

- **Perfil Lipídico:** Se debe mantener una dieta normal de grasas evitando el exceso y alcohol durante las **48 horas previas**.
- **Prueba de Tolerancia a la Glucosa (PTGO) y Glicemia post prandial:** El paciente debe mantener su alimentación habitual (sin restricción de carbohidratos) y actividad física normal los **3 días previos**. (Para mayores detalles sobre las indicaciones para los pacientes, véase “**Anexo 2 a. Glicemia pre y post prandial**” y “**Anexo 2 b. Prueba de tolerancia a la glucosa oral (P.T.G.O)**”)
- **Parasitológico Seriado:** Se debe evitar la ingesta de antibióticos, purgantes oleosos, carbón o medicamentos con calcio y bario **2 días antes** de iniciar la recolección.
- **Pruebas de Coagulación:** Idealmente deben realizarse sin el efecto de terapias anticoagulantes no recetadas o antiinflamatorios (AINEs). Los tiempos

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 11 de 76

sugeridos de suspensión (bajo criterio médico) son: **1 semana** para antagonistas de Vitamina K, **24 horas** para Heparina no fraccionada, **48 horas** para Heparina de bajo peso molecular y **3 días** para inhibidores directos.

- **Exámenes Microbiológicos:** Las muestras (orina, deposición, secreciones) deben tomarse **antes de iniciar cualquier terapia antibiótica**; si ya se inició, se debe registrar el nombre del fármaco en la solicitud.
- **Pacientes Diabéticos:** No deben tomar sus medicamentos orales ni inyectarse insulina hasta **después de obtenida la muestra** de sangre.
- **Antígeno Prostático (PSA):** Se debe guardar abstinencia sexual **2 días** antes del examen. Además, no se debe andar en bicicleta, caballo o motocicleta **48 horas antes**.
- **Exámenes de Orina y Secreciones Vaginales:** En mujeres, se debe evitar tener relaciones sexuales **12 a 24 horas antes** de la toma de muestra. No se debe realizar la toma durante el **periodo menstrual**; de ser urgente, se debe usar un tapón vaginal para evitar la contaminación con sangre.

2. Procedimientos Técnicos de Obtención de muestras.

2.1. Muestras de sangre.

2.1.1. Sistema para la extracción de muestra sanguínea

Para la obtención de muestras de sangre se puede utilizar el método tradicional (con jeringa) o el sistema al vacío (Vacutainer), de preferencia siempre escoger este último para obtener muestras en mejores condiciones. En la imagen siguiente se observa los componentes de un kit básico en cada método:

SISTEMA AL VACÍO  TUBO VACUTAINER: Es un tubo para depositar la muestra de sangre. Cerrado al vacío, con o sin anticoagulante y su capacidad fluctúa entre 1,8 y 10 ml.	SISTEMA TRADICIONAL  JERINGA DESECHABLE: Su capacidad de volumen dependerá de la cantidad de la muestra a extraer.
SISTEMA AL VACÍO  AGUJA MÚLTIPLE: Es una aguja específica para tomar muestras de sangre. Sirve para llenar varios tubos en la misma punción.	SISTEMA TRADICIONAL  AGUJA DESECHABLE: Para puncionar la vena o arteria, idealmente usar 21G.
SISTEMA AL VACÍO  MARIPOSA VACUTAINER: Es una aguja corta con tubo extensor.	SISTEMA TRADICIONAL  TUBO VACUTAINER: Es un tubo para depositar la muestra de sangre. Cerrado al vacío, con o sin anticoagulante y su capacidad fluctúa entre 1,8 y 10 ml.
SISTEMA AL VACÍO  ADAPTADOR O CAMISA (HOLDER): Cilindro plástico, el cual permite fijar la aguja.	

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 13 de 76

También existen diversos contenedores o tubos de distinto color y contenido en su interior. En la siguiente tabla un breve resumen de estos y su uso general en el laboratorio del servicio:

Tubos de toma de muestra			
Tapón	Contenido	Inversiones	Área de uso
Celeste 	Citrato de sodio	3 a 4 veces	Coagulación y perfil hepático
Amarillo 	Gel separador con activador de la coagulación	5 veces	Química clínica, serología (RPR, hepatitis, otros).
Rojo 	Gel separador con o sin activador de la coagulación	5 veces	Química clínica, serología (RPR, hepatitis, otros).
Verde 	Heparina de litio	8 a 10 veces	Química clínica (ex.: litemia)
Lila 	EDTA k2	8 a 10 veces	Hematología
Gris 	Fluoruro de sodio	8 veces	Química clínica, pruebas de glucosa.
Negro	Citrato de sodio	3 a 4 veces	VHS

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 14 de 76

2.1.2. Procedimiento: Toma de Muestra de Sangre Venosa

Personal Responsable: El procedimiento debe ser ejecutado por profesionales de salud capacitados: Enfermeras, Matronas, Tecnólogos Médicos o Técnicos de Nivel Superior de Enfermería (TENS) debidamente entrenados.

Materiales Necesarios:

- **Elementos de Protección Personal (EPP):** Guantes de procedimiento (no estériles), pechera plástica y, en caso de riesgo de salpicaduras, protección ocular y mascarilla quirúrgica.
- **Sistema de extracción:** Preferentemente sistema al vacío (agujas múltiples y camisa/holder). En casos de difícil acceso, jeringas de 5, 10 o 20 cc o mariposas (scalp vein).
- **Insumos de punción:** Torniquete o ligadura, alcohol etílico al 70%, tórulas de algodón (secas y embebidas en alcohol) y parches curitas o tela adhesiva.
- **Contenedores:** Tubos de recolección al vacío con o sin aditivos, según los exámenes solicitados.
- **Desecho:** Contenedor para material cortopunzante rígido y bolsa para desechos biológicos.

Procedimiento:

1. **Identificación del paciente:** Saludar al paciente e identificarlo verbalmente, corroborando sus datos (nombre, apellidos y RUN) con la orden médica y la cédula de identidad.
2. **Verificación de requisitos:** Verificar el cumplimiento de las condiciones de ayuno (idealmente 8 a 12 horas) y consultar sobre el uso de medicamentos que

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 15 de 76

puedan interferir con los resultados. *(Para más información véase “**Anexo 2 c. Exámenes de sangre en general**”)*

3. **Preparación del Paciente:** Explicar el procedimiento para disminuir la ansiedad. El paciente debe estar cómodamente sentado o acostado si su condición lo requiere y si estructuralmente se puede.
4. **Selección del sitio a puncionar:** Inspeccionar y palpar las venas del pliegue del codo (vena cubital mediana, cefálica o basílica) por ser de mejor calibre. Como alternativas se consideran el dorso de la mano o el pie, en caso de que el paciente no tenga un buen acceso venoso en las descritas anteriormente.
5. **Aplicación de Ligadura:** Colocar el torniquete entre 7 y 10 cm por encima del sitio de punción para favorecer el llenado venoso. Solicitar al paciente que empuñe la mano suavemente.
6. **Antisepsia:** Limpiar la zona con alcohol al 70% mediante movimientos circulares desde el centro a la periferia. Dejar secar el antiséptico antes de puncionar.
7. **Punción:** Estirar la piel con la mano no dominante para fijar la vena. Insertar la aguja con el **bisel hacia arriba** en un ángulo de 15 a 30 grados (según la profundidad de la vena).
8. **Recolección y Orden de llenado:** Introducir los tubos en el holder siguiendo el orden de llenado recomendado para evitar contaminación cruzada por aditivos:

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 16 de 76

Tubo tapa celeste (Citrato de Sodio).	
Tubo tapa amarilla/roja (Suero/Sin aditivo o con activador de la coagulación).	 
Tubo tapa verde (Heparina).	
Tubo tapa lila (EDTA).	
Tubo tapa gris (Fluoruro de sodio).	

9. **Liberación de la Ligadura:** Soltar el torniquete tan pronto como la sangre comience a fluir hacia el primer tubo. **Nunca retirar la aguja con el torniquete puesto.**
10. **Finalización:** Retirar la aguja con suavidad, colocar una tórula seca en el sitio y aplicar presión firme por 3 a 5 minutos (10 minutos si el paciente usa anticoagulantes). Indicar al paciente que no flexe el brazo.
11. **Homogeneización:** Invertir suavemente los tubos con aditivos (anticoagulantes) de 6 a 10 veces, dependiendo del tubo, inmediatamente después de llenarlos para asegurar la mezcla. **No agitar** por el riesgo a producir hemólisis.
12. **Rotulación:** Rotular cada tubo **frente al paciente** con su nombre completo y RUN inmediatamente después de la extracción o en su defecto pegar la etiqueta correspondiente.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 17 de 76

Nota: Frente a un fracaso en la punción, se debe reintentar la punción en la otra extremidad, NUNCA intentar más de dos veces en la misma vena o en la misma extremidad. Ante fallo de la punción, solicite ayuda de un tercero más calificado, en caso de ser posible.

Para saber la cantidad de tubos a tomar véase **“Anexo 3: Resumen de tubos por bacteria”** o consultar directamente a Laboratorio.

2.2. Muestras de orina.

2.2.1. Orina aislada o segundo chorro

Es importante para la obtención de resultados de buena calidad analítica, obtener una muestra de orina en condiciones asépticas, evitando la contaminación con microorganismos de la uretra anterior y la zona genital, para asegurar un análisis físico, químico y microbiológico confiable. Para esto se debe cumplir con una serie de pasos y requisitos por parte del paciente y el personal encargado.

Requisitos y Preparación del Paciente:

- **Momento de la toma:** Se debe preferir siempre la **primera orina de la mañana**, por ser la más concentrada.
- **Retención mínima:** Si no es la primera orina, el paciente debe tener una retención urinaria de al menos **3 a 4 horas**.
- **Ingesta de líquidos:** No se debe forzar la obtención de la muestra bebiendo abundantes líquidos, ya que esto diluye la orina y altera el recuento de microorganismos y analitos importantes, dejando de ser representativa del estado actual del paciente.
- **Consideraciones en mujeres:**
 - Evitar relaciones sexuales las 12 horas previas.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 18 de 76

- No realizar el examen durante el período menstrual. En casos de urgencia, se debe usar un tapón vaginal para evitar la contaminación con flujo sanguíneo y vaginal.

Para más información, para el paciente véase “Anexo 2 d. Orina completa-sedimento urinario para hombres”, “Anexo 2 e. Orina completa-sedimento urinario para mujeres” y “Anexo 2 f. Urocultivo y antibiograma”.

Materiales Necesarios:

- Frasco de plástico estéril de boca ancha con tapa rosca.
- Insumos para aseo genital: agua tibia, jabón líquido (idealmente pH neutro) y tómulas de algodón o gasas limpias.
- Guantes de procedimiento para el personal de salud.
- Etiquetas para rotulación.

Procedimiento:

A. Preparación e Higiene Genital: Es el paso crítico para evitar resultados falsos positivos.

1. **Lavado de manos:** El paciente (o el personal que asiste) debe realizar un lavado de manos prolijo con agua y jabón.
2. **Aseo genital:**
 - **Mujeres:** Separar los labios mayores y limpiar la zona con tómulas humedecidas en agua jabonosa, siempre **de adelante hacia atrás** en un solo movimiento. Repetir la operación y enjuagar con abundante agua para eliminar restos de jabón.
 - **Hombres:** Retraer el prepucio y limpiar el glande con agua jabonosa en movimientos circulares. Enjuagar con abundante agua.
3. **Secado:** Secar la zona con una gasa estéril o paño limpio y seco.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 19 de 76

B. Recolección de la Muestra (Técnica de Segundo Chorro):

1. Abrir el frasco estéril justo antes de usarlo, evitando tocar el interior de la tapa o del envase.
2. **Eliminar el primer chorro:** El paciente debe comenzar a orinar en el inodoro para limpiar la uretra de gérmenes contaminantes.
3. **Recolección:** Sin detener la micción, colocar el frasco y recolectar el **segundo chorro (chorro medio)** directamente en el envase estéril. El volumen requerido suele ser entre **20 y 60 mL** (o llenar hasta la mitad del frasco).
4. **Finalización:** Retirar el frasco y terminar de orinar en el inodoro.
5. **Cerrar** el frasco herméticamente.

C. Rotulación:

- **Rotulación:** Identificar el frasco inmediatamente con la etiqueta aportada en la entrega del frasco por parte del laboratorio o SOME.
- La etiqueta debe ir **sobre el frasco**, no en la tapa ni en el papel sobre el que recubre el frasco.
- En caso de extravió de la etiqueta o daño de esta, quedando ilegible, puede reemplazar con otra etiqueta de cinta de papel engomado o similar; asegurándose de rotular con el **nombre completo** del paciente.

D. Conservación y Transporte:

- **Tiempo ideal:** La muestra debe enviarse al laboratorio **inmediatamente** o antes de 2 horas a temperatura ambiente.
- **Refrigeración:** Si no se puede entregar antes de 2 horas, la muestra debe mantenerse refrigerada entre **2 y 8 °C**.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 20 de 76

- **Transporte:** Debe realizarse en gradillas, en posición vertical, dentro de un contenedor cerrado y a prueba de derrames.

2.2.2. Orina por recolector

Técnica utilizada en lactantes o niños que no controlan esfínteres. Principalmente ejecutada por personal técnico y profesional debido a la inocuidad y requerimientos necesarios para obtener una muestra de buena calidad.

Materiales Necesarios:

- Recolector de orina pediátrico
- Frasco de plástico estéril de boca ancha con tapa rosca.
- Insumos para aseo genital: agua tibia, jabón líquido (idealmente pH neutro) y tómulas de algodón o gasas limpias.
- Guantes de procedimiento para el personal de salud.
- Etiquetas para rotulación.

Procedimiento:

A. Preparación y Materiales:

- El personal encargado debe realizar un **lavado clínico de manos** antes de comenzar.
- Preparar todo el material a utilizar para el aseo genital: tómulas o gasas estériles, agua tibia y jabón suave (idealmente líquido y sin antiséptico). Debe ir en bandeja estéril y si no se cuenta con ello, en un espacio limpio y seco para evitar contaminación.
- Preparar material para la toma de muestra, **recolector de orina pediátrico y frasco estéril de boca ancha**.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 21 de 76

- Utilizar el EPP correspondiente (**guantes de procedimientos**).

B. Aseo Urogenital: Este paso es fundamental para evitar la contaminación de la muestra con flora bacteriana externa.

- **En niñas:** Se debe separar suavemente la zona genital externa (vulva) y lavar solo el área por la cual pasa la orina con abundante agua tibia y jabón. Se debe enjuagar bien y **secar con tórula o gasa estéril** de adelante hacia atrás una sola vez.
- **En niños:** Se debe limpiar el área genital con agua y jabón, **retrayendo suavemente el prepucio** para lavar el glande. Enjuagar con abundante agua tibia y secar prolijamente.

C. Instalación del Recolector:

- **Niñas:** Colocar el recolector desde la horquilla hacia arriba, sobre los labios mayores, presionando los bordes para asegurar que se **adhiera correctamente a la piel**.
- **Niños:** Colocar el recolector dejando **solo el pene en su interior**, presionando los bordes adhesivos para evitar filtraciones.
- Se recomienda indicar a los padres que mantengan al paciente en **posición vertical** y con el pañal suelto para facilitar la caída de la orina al dispositivo.

D. Tiempo de Espera y Cambio:

- El recolector debe permanecer adherido como **máximo 30 minutos**.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 22 de 76

- Si tras este tiempo el paciente no ha orinado, se debe **retirar el dispositivo, realizar nuevamente el aseo urogenital completo e instalar un nuevo recolector.**
- Se deben utilizar como máximo dos recolectores; la posibilidad de un tercero debe ser evaluada según las características del paciente.

E. Recolección y Rotulación:

- Una vez que el paciente ha orinado, se debe retirar y sellar el recolector.
- El recolector sellado se deposita dentro de un **frasco estéril de boca ancha** para evitar derrames y contaminación. No se debe intervenir ni puncionar el recolector.
- El envase debe ser **rotulado inmediatamente** con el nombre completo del paciente.

F. Transporte:

- La muestra debe enviarse **inmediatamente al laboratorio.**
- Durante el traslado, se debe mantener en **cadena de frío** utilizando unidades refrigerantes dentro de un contenedor cerrado.

2.2.3. Orina de 24 horas

El objetivo del este tipo de muestra es obtener una muestra de orina representativa de la excreción renal de un período exacto de 24 horas. Haciendo énfasis en la **estabilidad de los componentes** (metabolitos) y la exactitud del volumen total recolectado.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 23 de 76

Requisitos y Preparación del Paciente:

- No debe beber alcohol ni fumar durante las 24 horas de la recolección.
- Debe permanecer en **reposo relativo** (sin realizar esfuerzos vigorosos o ejercicios) el día anterior y durante el día de la toma de muestra.
- Se debe mantener el consumo de agua habitual, a menos que el médico indique lo contrario.
- **Consideraciones en mujeres:** No recolectar la muestra durante el **periodo menstrual**; esperar a que este finalice.

Para más información para entregar al paciente, véase “Anexo 2 g. Orina de 24 horas”.

Materiales Necesarios:

- **Contenedor de recolección:** Recipiente plástico limpio, de boca ancha y con capacidad mínima de 2 a 3 litros (pueden ser necesarios varios recipientes). Puede ser una o más botella de bebida, idealmente de agua mineral, de 3 litros limpia y seca, sin residuos.
- Para rotulación: Etiquetas con el nombre completo del paciente y solicitud de examen.
- En laboratorio, **frasco limpio y seco** para la obtención de una alícuota.

Procedimiento:

A. Recolección de la muestra por el paciente:

1. Establecer una hora fija de inicio, por ejemplo a las **08:00 AM**. Siempre que sea la primera orina del día
2. **Eliminar la primera orina:** A la hora de inicio (ej. 08:00 AM), el paciente debe orinar en el inodoro y descartar esa muestra. Esta orina **no se guarda**.
3. Registrar la hora exacta de este descarte en el contenedor.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 24 de 76

4. **Recolección total:** A partir de ese momento, **toda la orina** emitida durante el día y la noche debe guardarse en el recipiente.
5. Si el paciente tiene necesidad de defecar, debe orinar primero para evitar que la muestra se contamine con deposiciones.
6. **Importante:** Si por alguna razón se pierde una micción o se recolecta por más de 24 horas, el procedimiento pierde validez y debe reiniciarse al día siguiente.
7. Al día siguiente, a la **misma hora registrada el día anterior** (ej. 08:00 AM), el paciente debe realizar la última micción y guardarla íntegramente en el contenedor.

B. Manejo Post-Recolección (laboratorio):

- **Homogenización:** Mezclar bien toda la orina recolectada (si hay varios bidones, juntarlos y mezclarlos).
- **Medición de diuresis:** Medir el volumen total y registrarlo claramente en la solicitud de examen como **Diuresis de 24 horas**.
- **Traspaso:** Llenar el frasco con una muestra (alícuota) de la orina homogenizada (entre 5 a 10 mL).

C. Conservación y Transporte:

- **Conservación:** Durante todo el proceso de recolección, el contenedor debe mantenerse en un lugar fresco, idealmente **refrigerado (2 a 8 °C)** y protegido de la luz solar.
- **Transporte:** Enviar la muestra al laboratorio lo antes posible (idealmente antes de 2 a 4 horas de terminada la recolección) a temperatura ambiente.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 25 de 76

2.2.4. Orina por sondeo vesical

Personal Responsable: Debe ser realizado por personal profesional debidamente entrenado (Enfermeras, Matronas) o técnicos paramédicos bajo supervisión.

Materiales Necesarios:

- **Equipo de sondeo vesical estéril:** Riñón, paño perforado, tómulas o apósitos y pocillo/copela.
- **Sonda vesical:** Tipo Nélaton o Foley (calibre adecuado según el paciente, habitualmente N°12 a 16).
- **Guantes:** guantes de procedimiento y guantes estériles.
- **Antisepsia e Higiene:** Solución jabonosa, agua tibia, tómulas de algodón o gasas estériles y lubricante estéril (glicerina o vaselina líquida).
- **Recolección:** Frasco estéril para urocultivo y orina completa.
- **Protección Personal (EPP):** Pechera plástica y mascarilla.

Procedimiento:

A. Preparación del Paciente:

1. Identificar al paciente y verificar la orden médica.
2. **Explicar el procedimiento** al paciente y/o familiares para obtener su colaboración.
3. **Posicionamiento:** Colocar al paciente en decúbito supino (hombres) o posición ginecológica (mujeres).

B. Higiene Genital:

4. Realizar lavado clínico de manos y colocarse guantes de procedimiento.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 26 de 76

5. Realizar **aseo genital prolijo** con agua y jabón:

- **Mujeres:** Separar los labios mayores y limpiar con apósitos mojados de adelante hacia atrás en un solo movimiento.
- **Hombres:** Retraer el prepucio y asear el glande de forma circular desde el meato hacia afuera.

6. Enjuagar con abundante agua y secar con gasas estériles.

C. Instalación y Recolección:

- Retirar guantes de procedimiento y realizar un nuevo lavado de manos (quirúrgico o clínico profundo).
- Colocarse **guantes estériles** y disponer el campo estéril (pañó perforado) sobre la zona genital, en lo posible y si las condiciones estructurales lo permiten.
- Lubricar la punta de la sonda con glicerina o vaselina estéril, o usar directamente si viene lubricada de fábrica.

10. Introducción de la sonda:

- **Mujeres:** Separar labios menores, visualizar el meato urinario e introducir la sonda suavemente sin tocar otras superficies, en dirección hacia arriba y hacia atrás aproximadamente de 5 a 7 cm hasta que comience a fluir la orina.
- **Hombres:** Elevar el pene en un ángulo de 60° a 90° e introducir la sonda suavemente por el meato urinario. Avanzar unos 15 a 20 cm hasta llegar a la zona de resistencia (esfínter externo), bajar el pene a un ángulo de 45° aproximadamente. Se le pide al paciente que respire profundo para relajar la musculatura y que fluya la orina.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 27 de 76

Nota crítica de seguridad: El procedimiento debe suspenderse inmediatamente si se encuentra una resistencia inusual al avanzar la sonda, para evitar la creación de falsas vías o trauma uretral.

11. Obtención de la muestra:

- Permitir que escurran los primeros mL de orina (primer chorro) para limpiar la uretra.
- **Desechar el primer chorro**, los primeros 2 a 3 mL de orina hacia la bandeja o chata, ya que pueden arrastrar bacterias del tramo distal de la uretra.
- Colocar el frasco estéril bajo el flujo de la sonda y recolectar la cantidad necesaria, entre 5 a 10 mL.
- Tapar inmediatamente el frasco de forma estéril sin tocar los bordes internos.
- Retirar la sonda con un movimiento suave pero continuo. En hombres, volver a colocar el prepucio en su posición normal para evitar una parafimosis.

12. Fase Posterior y Registro:

- Limpiar los restos de lubricante o antiséptico de la zona genital del paciente y dejarlo en una posición cómoda.
- Desechar todo el material utilizado en los contenedores de residuos correspondientes (especiales y comunes o domiciliarios).
- Retirarse los guantes y realizar higiene de manos.
- **Rotulación:** Etiquetar el frasco de la muestra con **Nombre completo** y método de obtención (Sondeo Vesical).

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 28 de 76

2.2.5. Orina por catéter urinario permanente (CUP) o sonda Foley

Para obtener una muestra de orina desde un dispositivo de drenaje urinario ya instalado, asegurando la integridad del sistema cerrado y que esta sea representativa y libre de contaminación externa es necesario cumplir con una serie de requisitos y pasos.

Requisitos y Consideraciones Importantes:

- **Sistemas de larga permanencia:** Si el catéter lleva instalado más de 24 horas, se recomienda (según criterio clínico) realizar un cambio de sonda y tomar la muestra del nuevo dispositivo, ya que las sondas permanentes suelen estar colonizadas por microorganismos después de 48-72 horas.
- **Prohibición crítica: NUNCA** se debe recolectar la muestra directamente desde la bolsa de recolección, ya que el crecimiento bacteriano en el receptáculo altera los resultados.
- **No pinzar:** No se debe pinzar la sonda para forzar la acumulación de orina antes de la toma.

Materiales Necesarios:

- Guantes (de procedimiento o estériles).
- Jeringa estéril de 10 mL y aguja (calibre 21 G o 24 G).
- Alcohol al 70% y tómulas de algodón o gasas.
- Frasco estéril para recolección.
- Elementos de protección personal (pechera desechable si hay riesgo de salpicaduras).

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 29 de 76

Procedimiento:

1. **Identificación y Preparación:** Verificar la identidad del paciente y explicar el procedimiento (si su nivel de conciencia lo permite).
2. **Higiene de Manos:** Realizar lavado clínico de manos y colocarse los guantes.
3. **Selección y Desinfección del Sitio:**
 - Ubicar el segmento proximal de la sonda (cerca del meato urinario o en el puerto de punción diseñado para tal fin).
 - Desinfectar prolijamente el sitio de punción con una tórula con **alcohol al 70%** y esperar a que seque completamente.
4. **Extracción de la Muestra:**
 - Insertar la aguja en el sitio desinfectado en un ángulo de **30°** (cuidando de no puncionar el lumen del balón o *cuff*).
 - Aspirar con la jeringa la cantidad de orina requerida (generalmente entre **2 y 10 mL** para urocultivo y otros análisis).
5. **Traspaso y Cierre:**
 - Vaciar la orina inmediatamente en el frasco estéril
 - Eliminar el material cortopunzante en el contenedor adecuado sin reencapsular la aguja.
6. Retirarse los guantes, realizar higiene de manos.
7. Identificar el contenedor inmediatamente con nombre completo del paciente y que el procedimiento fue “CUP”
8. Enviar la muestra al laboratorio lo antes posible. Si el traslado demora más de 2 horas, debe mantenerse refrigerada entre **2 y 8 °C**

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 30 de 76

2.3. Muestras de deposiciones.

La calidad de las muestras de deposiciones, para las diversas prestaciones ofrecidas por el laboratorio, dependen directamente de la responsabilidad del paciente en el seguimiento de las indicaciones y requisitos aportados para la obtención de estas mismas. Por tanto, es necesario **instruir adecuadamente** al paciente sobre los requisitos y pasos a seguir con el fin de asegurar que la muestra esté en condiciones de calidad óptimas.

2.3.1. Parasitológico seriado de deposiciones (PSD)

El Parasitológico seriado de deposiciones o PSD, es un examen enfocado en detectar la presencia de **enteroparásitos** (quistes de protozoos, huevos o larvas de helmintos) mediante el análisis microscópico de muestras de deposiciones recolectadas de forma seriada.

Requisitos y Preparación del Paciente:

- **Restricción de medicamentos:** El paciente no debe ingerir **antibióticos, quimioterapéuticos, antiparasitarios, purgantes oleosos**, ni medicamentos con **bario, calcio o carbón** durante los **2 días previos** al inicio de la recolección.
- **Dieta:** No se requiere una dieta restrictiva especial para este examen.
- **ADVERTENCIA:** El líquido de los frascos es un fijador (PAF o SAF) que contiene sustancias tóxicas (fenol-alcohol-formalina); **no debe ser ingerido, botado ni vaciado**, y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Para entregar más información al véase “Anexo 2 h. Parasitológico seriado de deposiciones (P.S.D.)”

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 31 de 76

Materiales Necesarios:

- **Kit de recolección: 1 frasco** con solución fijadora.
- **Paletas o espátulas** de madera o plástico para la manipulación o la paleta que viene de fabrica en el frasco de muestra.
- Recipiente limpio y seco (chata o bacinica) para la emisión de la deposición.
- Guantes de procedimiento para el personal o el cuidador.

Procedimiento:

A. Recolección de la muestra:

1. Se debe recolectar una muestra **día por medio** (ejemplo: lunes, miércoles y viernes) dentro del mismo frasco, a menos que el médico indique recolección diaria.
2. El paciente debe defecar en el recipiente limpio y seco, evitando estrictamente la contaminación con **orina, agua o papel higiénico**.
3. Con la paleta, tomar una porción de deposición del tamaño de un **poroto o una nuez pequeña** (aprox. 5 gramos). Si la muestra es líquida, se deben recolectar aproximadamente **4 cucharaditas o 1 cc**.
4. Si la deposición presenta sangre, mucosidad o pus, se debe recolectar preferentemente de esa zona.
5. Depositar la muestra en el frasco correspondiente y **mezclar muy bien** con el líquido fijador hasta formar una pasta homogénea.

B. Casos Especiales:

- **Lactantes o pacientes con pañal:** Se debe tomar la muestra recién emitida directamente del pañal, siempre que no esté contaminada con orina.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 32 de 76

- **Hallazgo de parásitos:** Si se observan elementos blanquecinos o gusanos macroscópicos, estos deben colocarse en un **frasco aparte limpio solo con agua de la llave**.

C. Rotulación e Identificación:

- Identificar cada frasco inmediatamente con el **nombre completo** o la etiqueta aportada en la entrega de material. **IMPORTANTE**, debe pegar la etiqueta en el frasco, no en la bola con la que transporte el frasco.
- Se recomienda rotular también la caja o bolsa que contenga el frasco.

D. Conservación y Transporte:

- Durante el periodo de recolección, los frascos deben mantenerse a **temperatura ambiente (20-25 °C)** en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar. **No se deben congelar**.
- Se deben enviar el frasco al laboratorio **solo después de obtenida la última muestra**.
- **Plazo de transporte:** La entrega debe realizarse lo antes posible, idealmente antes de **24 horas** tras la recolección final.

2.3.2. Test de Graham

Este examen tiene como propósito la búsqueda y detección de huevos de *Enterobius vermicularis* (pidulles).

Requisitos y Preparación del Paciente:

- La muestra debe obtenerse obligatoriamente **a primera hora de la mañana**, apenas el paciente despierte.
- Se debe realizar **antes de que el paciente se bañe, orine o defeque**.
- **Restricciones:**

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 33 de 76

- La noche anterior no se deben aplicar pomadas, talcos ni lociones en la zona anal.
- No se deben utilizar laxantes antes del examen.
- Se recomienda no haber ingerido medicamentos antiparasitarios al menos los **3 días previos** al inicio de la recolección.
- Con niños y adultos mayores que necesiten asistencia, la toma de muestra debe ser realizada por un familiar o cuidador.

Para más información para entregar al paciente, véase “Anexo 2 i. Test de Graham”.

Materiales Necesarios:

- **Kit de recolección:** Consiste en un sobre o caja con **5 láminas de vidrio** (portaobjetos), cada una con una tira de cinta adhesiva transparente (scotch) adherida a su superficie.
- Papel blanco para envolver cada lámina.
- Guantes de procedimiento para quien realiza la toma.

Procedimiento:

1. El ejecutor debe realizar un lavado clínico de manos y colocarse guantes.
2. **Preparación de la lámina:** Tomar una lámina de vidrio y desprender la cinta adhesiva de uno de sus extremos, cuidando de **no tocar el lado engomado** con los dedos.
3. Entreabrir los glúteos del paciente para exponer la zona perianal.
4. Realizar varias **tocaciones (pegar y despegar)** con el lado engomado de la cinta en todo el contorno del ano y entre las nalgas.
5. Si se observa algún gusano (pidulle) visible, este debe ser adherido también a la cinta.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 34 de 76

6. Pegar la cinta nuevamente sobre la lámina de vidrio, asegurándose de que quede **bien estirada, derecha y sin burbujas**. La muestra no debe contener deposiciones.
7. Envolver la lámina en el papel entregado y rotularla inmediatamente o bien dejarla dentro del sobre rotulado con su **nombre completo**.
8. Repetir este procedimiento durante **5 días consecutivos**, utilizando una lámina diferente cada mañana.
9. Durante los 5 días de recolección, las láminas deben mantenerse a **temperatura ambiente** (15-25 °C) en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
10. Se deben enviar las **5 muestras juntas** al laboratorio una vez completada la recolección del quinto día.
11. El traslado debe realizarse en un contenedor cerrado y la entrega no debe superar las **24 horas** tras la obtención de la última muestra.

2.3.3. Sangre oculta en heces

Este examen es útil para detectar la presencia de **sangre no visible (oculta)** o sus derivados en las heces, como apoyo en el tamizaje de cáncer de colon o la pesquisa de sangrados gastrointestinales.

Requisitos y Preparación del Paciente

Para que el examen sea representativo, se deben seguir estrictamente estas indicaciones:

- **Dieta:** En las técnicas actuales por inmunocromatografía, **no se requiere una dieta restrictiva** previa al examen.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 35 de 76

- **Medicamentos:** Bajo supervisión médica, se recomienda evitar la ingesta de vitamina C, aspirina, antiinflamatorios, corticoides, suplementos de hierro o medicamentos con ácido acetilsalicílico desde **4 días antes** de la muestra.
- **Condiciones clínicas:**
 - No realizar la recolección durante el **periodo menstrual**; se debe esperar al menos 3 días después de que este haya finalizado.
 - No tomar la muestra si existen **hemorroides sangrantes** o sangre en la orina; esperar 3 días después de que el sangrado haya cesado por completo.
 - Evitar la toma de muestra si el paciente presenta **estreñimiento** severo.

*Para entregar más información al véase “**Anexo 2 j. Test de hemorragias ocultas**”*

Materiales Necesarios:

- Frasco de plástico limpio y seco, con tapa rosca, sin aditivos ni conservantes.
- Paleta de madera o espátula plástica para la recolección.
- Recipiente limpio para la emisión de la muestra (chata o bacinica).

Procedimiento:

1. Realizar un prolijo lavado clínico de manos y utilizar guantes de procedimiento, en lo posible.
2. El paciente debe defecar en un recipiente limpio y seco, cuidando estrictamente de **no mezclar la deposición con orina o agua**.
3. Con la paleta, tomar una pequeña cantidad de muestra del tamaño de un **poroto o almendra** (aproximadamente 2 a 3 gramos). Si la deposición es líquida, recolectar hasta **5 mL**.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 36 de 76

4. El examen habitualmente requiere **3 muestras consecutivas** obtenidas en días diferentes (no necesariamente sucesivos, pueden ser intercalados).
5. Las 3 muestras se deben depositar en el **mismo frasco** entregado por el laboratorio, asegurándose de cerrarlo bien después de cada adición.
6. **En Lactantes y postrados**, la muestra puede tomarse directamente del pañal, siempre que la deposición sea recién emitida y no esté contaminada con orina, cremas o talco.
7. Rotular e identificar el frasco inmediatamente con el **nombre completo** y la fecha de la última recolección.
8. Durante el periodo de recolección de los tres días, el frasco debe mantenerse en un lugar **fresco, seco y protegido de la luz solar**. Se recomienda mantenerlo **refrigerado (2 a 8 °C)**, apartado de los alimentos.
9. La muestra debe enviarse al laboratorio **después de obtenida la última recolección**. El **traslado** debe ser a **temperatura ambiente** (si es antes de 24 horas) o refrigerada, en un contenedor cerrado a prueba de derrames.

2.4. Secreciones y otros

2.4.1. Respiratorias (expectoración)

El objetivo de obtención de esta muestra es para detectar la presencia de *Mycobacterium tuberculosis* en muestras del tracto respiratorio inferior mediante baciloscopía (tinción de Ziehl-Neelsen), cultivo líquido (MGIT) o pruebas de biología molecular (PCR en tiempo real).

Requisitos y Preparación del Paciente:

Para garantizar la calidad de la muestra y la seguridad del proceso, el paciente debe seguir estas instrucciones:

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 37 de 76

- La muestra debe obtenerse idealmente **en ayunas**.
- Antes de la toma, el paciente debe realizarse un enjuague bucal **solo con agua** para eliminar restos de comida y flora normal; **no debe usar pasta dental** ni antisépticos bucofaríngeos.
- Se debe obtener **esputo bronquial** ("flema" de las profundidades del pecho) y evitar estrictamente la recolección de saliva, ya que esta última no tiene valor diagnóstico.
- Si el paciente ya está en tratamiento antituberculoso, este **no debe suspenderse** para los exámenes de control.

Materiales Necesarios:

- **Frascos de recolección:** Dos frascos limpios de boca ancha con tapa rosca hermética.
- Guantes de procedimiento y mascarilla N95 para el personal de salud (en caso de asistir el procedimiento).
- Bolsas plásticas para el transporte individual de los frascos.
- Etiquetas para rotulación.

Procedimiento :

1. El procedimiento debe realizarse en un **lugar bien ventilado**, idealmente al aire libre o en un espacio individual, para evitar la concentración de aerosoles infectantes.
2. **Técnica de obtención:**
 - Indicar al paciente que inspire profundamente llenando los pulmones tanto como sea posible.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 38 de 76

- Retener el aire por un momento y luego **toser con fuerza** para expulsar la secreción bronquial.
 - Depositar el desgarro directamente en el frasco, evitando contaminar las paredes exteriores.
3. Se requiere un volumen mínimo de **2 a 5 mL** por muestra.
 4. Para el diagnóstico inicial, generalmente se solicitan **dos muestras** (pueden ser seriadas inmediatas o de dos días consecutivos, según la norma local).
 5. Si el paciente no logra expectorar, se puede inducir mediante nebulización con suero fisiológico con **cloruro de sodio al 3%** durante 20 minutos o mediante maniobras kinésicas.

Nota crítica: No se debe usar suero fisiológico simple para facilitar la aspiración, ya que diluye la muestra y altera los resultados cuantitativos. *(Para entregar más información al paciente, véase “Anexo 2 k. Muestra de esputo (baciloscopia – TBC)”)*

6. Identificar cada frasco en sus paredes (no en la tapa) con el **nombre completo** del paciente.
7. **Solicitud de examen:** Debe completarse íntegramente incluyendo dirección, teléfono y especificando el **motivo del examen** (Pesquisa, Control de tratamiento, etc.) y antecedentes de tratamientos previos (Caso nuevo, Recaída, Fracaso). **(Anexo 4: Orden de estudio bacteriológico TBC)**
8. Una vez obtenida, la muestra debe mantenerse **refrigerada entre 2 y 8 °C** y protegida de la luz solar directa. No debe congelarse.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 39 de 76

9. Debe enviarse al laboratorio lo antes posible (idealmente antes de 4 horas) en posición vertical, dentro de un contenedor cerrado y utilizando unidades refrigerantes.
10. Se exige el uso de **triple embalaje** para el transporte seguro de sustancias infecciosas hacia centros de referencia.

2.4.2. Urogenitales SGB

El tamizaje de *Streptococcus agalactiae* (Streptococcus Grupo B o SGB) se realiza de forma rutinaria en personas gestantes (generalmente entre las semanas 35 y 37 de embarazo) para prevenir la transmisión vertical al recién nacido durante el parto. El procedimiento estandarizado para la toma de muestra vagino-rectal (torulado), debe ser realizado por personal de salud cualificado (personal técnico bajo vigilancia o matrona).

Requisitos y Preparación del Paciente:

- **No es necesario el uso de espéculo** para este procedimiento.
- No se deben utilizar antisépticos ni lubricantes en la zona antes de la toma.
- Se debe explicar el procedimiento a la paciente para obtener su consentimiento y asegurar su comodidad.

Materiales Necesarios:

- Una tórula (hisopo) de dacrón o rayón con medio de transporte (ej. Amies o Stuart).
- Guantes de procedimiento no estériles.
- Etiquetas para rotulación de la muestra.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 40 de 76

- Formulario de solicitud de examen (órden médica).

Procedimiento:

A. Muestra Vaginal

1. Solicite a la paciente que se coloque en posición ginecológica (litotomía).
2. Lávese las manos y colóquese los guantes de procedimiento.
3. Con una mano, separe suavemente los labios mayores para exponer el introito vaginal.
4. Con la otra mano, introduzca la tórula aproximadamente **1 a 2 centímetros** en el tercio inferior de la vagina (introito).
5. Gire la tórula suavemente contra las paredes vaginales durante unos segundos para asegurar la recolección de la secreción.

B. Muestra Perianal / Rectal:

6. Utilizando otra **tórula**, desplácese hacia la región anal.
7. Introduzca la punta de la tórula a través del esfínter anal (aproximadamente **0.5 a 1 centímetro**).
8. Gire suavemente la tórula para tomar contacto con la mucosa rectal y la zona perianal.

Nota: La tórula debe teñirse ligeramente con trazas de materia fecal; si está excesivamente cargada, puede dificultar el cultivo, pero una muestra limpia del esfínter es correcta.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 41 de 76

C. Conservación y Transporte:

9. Introduzca inmediatamente la tórula en el tubo con el medio de transporte, asegurándose de que quede bien sellado.
10. Rotule el tubo con el **nombre completo de la paciente**
11. Mantenga la muestra a **temperatura ambiente** (15°C a 25°C) y enviar al laboratorio de inmediato.

2.4.3. Directo al fresco

El **examen directo al fresco** es un procedimiento microbiológico rápido que permite la observación inmediata de microorganismos móviles (como parásitos) o estructuras fúngicas en diversas muestras biológicas. Su aplicación más frecuente se da en el estudio de **flujo vaginal**.

Directo al Fresco de Flujo Vaginal: Utilizado principalmente para el diagnóstico de vaginitis, permitiendo identificar la presencia de *Trichomonas vaginalis*, levaduras o *clue cells*.

Requisitos y Preparación de la Paciente:

- **Periodo menstrual:** No debe estar menstruando; de lo contrario, esperar al menos 5 días tras el término del periodo.
- **Medicamentos:** No utilizar óvulos, cremas, pomadas ni soluciones antisépticas vaginales durante las **48 horas previas**.
- **Higiene:** El día del examen no debe realizarse duchas vaginales.
- **Abstinencia:** No haber tenido relaciones sexuales en las **24 horas previas**.

Materiales Necesarios:

- Espéculo vaginal estéril (sin lubricantes, puede usarse agua templada).

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 42 de 76

- Tórulas de algodón estériles.
- **Tubo estéril con 1 a 2 mL de suero fisiológico estéril** (insumo crítico para mantener la viabilidad y movilidad de los microorganismos).
- Guantes de procedimiento.

Procedimiento:

1. Verificar la identidad de la paciente y colocarla en posición ginecológica.
2. Introducir el espéculo y, bajo observación directa, frotar suavemente la tórula contra las paredes de la mucosa vaginal y los fondos de saco para impregnarla con el flujo.
3. **Preparación para Directo:** Introducir la tórula inmediatamente en el tubo con los **1-2 mL de suero fisiológico**.
4. **Finalización:** Retirar el espéculo, rotular el tubo con los datos del paciente y tipo de muestra, y realizar lavado de manos.
5. Transportar el tubo al laboratorio a temperatura ambiente inmediatamente para su procesamiento (antes de 2 horas).

3. Manejo post-toma de muestras

3.1. Rotulación e identificación

Es un componente crítico de la etapa preanalítica, por lo cual se desarrollará un apartado separado para hacer énfasis en la importancia de la rotulación, con el fin de garantizar la trazabilidad de los especímenes y la seguridad del paciente, evitando **errores de asociación** que podrían invalidar los resultados.

A continuación, se detalla el procedimiento técnico para su integración en el equipo de salud:

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 43 de 76

3.1.1. Identificación de Muestras

Toda muestra biológica debe ser identificada obligatoriamente de forma presencial **inmediatamente después de la extracción** y siempre frente al paciente. El profesional o técnico que realiza la toma es el responsable directo de que la rotulación sea correcta y coincida íntegramente con los datos de la solicitud de examen.

A. Identificación Manual de Muestras:

En servicios donde no se disponga de etiquetas automatizadas, se debe proceder de la siguiente manera:

- **Datos mínimos:** Se debe escribir con letra clara, legible y usando lápiz de tinta permanente que no se borre con el roce, el **nombre completo (dos nombres y dos apellidos)** y el **RUN del paciente**. En el caso de postas se debe, además, agregar un número de trazabilidad interno en la etiqueta en la parte superior del tubo el cual debe coincidir con todas las muestras del paciente y la orden o solicitud de examen.
- **Criterio de concordancia:** En la recepción del laboratorio se verificará que los datos del rótulo coincidan exactamente con la solicitud de exámenes; de existir discordancia, **la muestra será rechazada**.
- **Casos especiales de rotulación manual:**
 - **Recién Nacidos sin registro:** En tubos de volumen pequeño (menos de 3 mL), se debe asegurar que al menos los dos apellidos sean claramente visibles. Se deben rotular como "HIJO(A) DE [Nombres y Apellidos de la madre]".
 - **Gemelos:** Identificar como G1 "Hijo(a) de..." y G2 "Hijo(a) de...", señalando el nombre completo de la madre en ambos casos.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 44 de 76

B. Rotulación Automatizada (Códigos de Barra)

El uso de etiquetas generadas por el **Sistema de Información de Laboratorio o SIL** (actualmente se ocupa Nobilis de Wiener) es el estándar para asegurar la trazabilidad electrónica.

- **Contenido de la etiqueta:** Incluye el código de barras (número de orden), nombre y apellidos del paciente, RUN, procedencia, exámenes solicitados, sección del laboratorio a la que va dirigida, color de la tapa del tubo y fecha.
- **Verificación previa:** Antes de la punción, el flebotomista debe corroborar la identidad del paciente y verificar que la cantidad de etiquetas generadas sea suficiente para todos los contenedores requeridos. Debe contrastar que los datos coincidan en el ID o carnet del paciente, en la solicitud de exámenes y en las etiquetas generadas por el SIL.

3.1.2. Técnica Correcta de Etiquetado en Contenedores

Para facilitar el procesamiento analítico y la inspección visual, las etiquetas deben pegarse siguiendo estas directrices:

- **En Tubos (Adultos):** La etiqueta se debe pegar de forma **horizontal o longitudinal**, desde el borde de la tapa hacia abajo. Es fundamental dejar libre una parte del tubo para permitir la observación del contenido y verificar la calidad de la muestra (presencia de hemólisis, coágulos o nivel de llenado) sin tener que abrirlo.
- **En Microtubos:** La etiqueta debe pegarse de forma perpendicular al tubo o al tubo de soporte en el caso de microtubos pediátricos.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 45 de 76

- **En Frascos (Orina, Deposición):** La etiqueta debe pegarse siempre en el **cuerpo del frasco** y **NUNCA en la tapa**, para evitar confusiones de identidad al momento de procesar la muestra en el laboratorio.

3.1.3. Identificación para Exámenes con Resguardo de Identidad (VIH)

Las muestras para la detección de VIH deben ajustarse a la normativa ministerial vigente y completarse la orden junto con su consentimiento informado correspondiente (*Anexo 5: Orden de VIH*):

- Se utiliza un **código de identificación (clave)** en lugar del nombre del paciente para mantener la confidencialidad.
- **Construcción del código:** Se forma con la inicial del primer nombre, inicial del primer apellido, inicial del segundo apellido, fecha de nacimiento (dd/mm/aa), los tres últimos dígitos del RUN y el dígito verificador.
- **Ejemplo:** Para Juana Pérez Cofré, RUN 15.808.567-1, nacida el 11-03-1975, el código sería **JPC110375567-1**.
- Si la persona tiene un solo apellido, el código se construye con la primera letra del primer nombre, la primera del apellido, **un signo #**, fecha de nacimiento (ddmmaa), los tres últimos dígitos del RUN y el dígito verificador.
- En el caso de pacientes **extranjeros sin RUN**, el código debe construirse con la inicial del primer nombre, inicial del primer y segundo apellido, fecha de nacimiento (dd/mm/aa) y se completa con **ABC-D**.

3.2. Conservación de muestras

Para asegurar la **estabilidad de los analitos** en las muestras biológicas y evitar el deterioro o alteración de estas antes del proceso analítico, es imperativo cumplir con condiciones de almacenamiento adecuadas según el tipo de examen.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 46 de 76

3.2.1. Definición de Rangos de Temperatura

Para fines de estandarización en el manejo de especímenes, se establecen los siguientes rangos térmicos generales:

- **Temperatura Ambiente:** Fluctuaciones controladas entre **15 y 25 °C**.
- **Temperatura de Refrigeración:** Mantenimiento constante entre **2 y 8 °C**.
- **Temperatura de Congelación:** Igual o inferior a **-20 °C**.
- **Calor Metabólico (35 - 37 °C) o temperatura corporal:** Muestras que requieren transporte en baño de agua tibia o contacto directo con el cuerpo.

3.2.2. Consideraciones Generales por Tipo de Muestra

1. Muestras de Sangre:

- La mayoría de los tubos de bioquímica (tapa roja/amarilla) y hematología (tapa lila) pueden mantenerse a **temperatura ambiente** hasta por 4 horas si el traslado es inmediato.
- Exámenes fotolábiles (como **Vitamina B12, Bilirrubina o Folatos**) deben ser **protegidos de la luz** mediante papel oscuro (calco) o envoltorios opacos.

2. Muestras de Orina:

- Deben ser enviadas al laboratorio preferentemente antes de **2 horas** tras su recolección.
- Si no es posible el envío inmediato, deben conservarse refrigeradas entre **2 y 8 °C** para evitar la proliferación bacteriana y la degradación de elementos del sedimento.
- La **Orina de 24 horas** debe mantenerse refrigerada durante todo el proceso de recolección.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 47 de 76

3. Muestras de Microbiología:

- Los cultivos de secreciones en medios de transporte (Stuart, Amies) se conservan generalmente a **temperatura ambiente**.
- Muestras para **Tuberculosis (TBC)** deben refrigerarse a 4 °C y protegerse de la luz solar.

3.2.3. Estabilidad y Trazabilidad

- **Uso de Preservantes:** En casos específicos, como el PSD, se utilizan líquidos fijadores (PAF/SAF) que permiten la conservación a temperatura ambiente.
- **Posición de Almacenamiento:** Los tubos y frascos deben permanecer siempre en **posición vertical** para evitar la agitación violenta y prevenir la hemólisis o derrames.
- **Registro:** El personal debe consignar en la orden médica o sistema informático la **fecha y hora** de la toma de muestra para verificar el cumplimiento de los tiempos máximos de estabilidad.

3.2.4. Conservación post análisis

Las muestras se conservarán en el laboratorio durante un tiempo limitado posterior a su análisis clínico y esto dependerá del tipo de tubo o muestra y de las capacidades físicas-estructurales del laboratorio.

- Tubos de sangre total y suero: se mantendrán en las dependencias del laboratorio, refrigeradas, como máximo 1 semana posterior a su análisis.
- Frascos de orina: se mantendrán refrigeradas como tiempo máximo 48 horas
- Frascos con deposiciones: se eliminarán el mismo día de procesamiento.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 48 de 76

3.3. Transporte y traslado

El transporte debe efectuarse de la manera más cercana posible al momento de la extracción o de forma inmediata, según la especificación técnica de cada examen. La rapidez en el traslado es vital para evitar factores que deterioren la muestra, tales como el tiempo de exposición, la luz, la temperatura inadecuada y la hemólisis.

3.3.1. Requisitos Generales de Transporte

- **Posición y Cierre:** Todos los tubos y frascos deben estar correctamente tapados y ser transportados en **posición vertical** dentro de gradillas para evitar la agitación violenta y posibles derrames.
- **Contenedores Separados:** Las muestras bacteriológicas, de orina y de sangre deben transportarse en contenedores diferentes para evitar contaminaciones cruzadas.
- **Temperatura:** Las muestras a temperatura ambiente no deben mezclarse en el mismo contenedor con aquellas que requieren refrigeración.
- **Identificación:** Ninguna muestra debe ser trasladada si no cuenta con todos los datos de identificación del paciente y su orden de examen respectiva.

3.3.2. Traslado Interno (Dentro de la Institución)

Para el movimiento de muestras desde los servicios clínicos o boxes de toma de muestras hacia el laboratorio central, se deben seguir estos protocolos:

1. **Contenedor Secundario:** Utilizar cajas termoaislantes con tapa hermética (tipo cooler) que posean el **distintivo de riesgo biológico** visible.
2. **Organización Interna:** En el interior del cooler, las muestras deben ir en gradillas, rodeadas de material absorbente y, si el examen lo requiere, con unidades refrigerantes que no tengan contacto directo con los tubos.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 49 de 76

3.3.3. Traslado Externo (Desde Centros de la Red como las Postas)

Las muestras provenientes de establecimientos externos deben cumplir plazos estrictos y logística de cadena de frío:

- **Horarios de Traslado:** Generalmente se establecen bloques horarios (ej. 10:00 y 12:00 hrs) para el envío regular en contenedores tipo coleman con unidades refrigerantes.
- **Tiempos de Ingreso:** La mayoría de las muestras de sangre deben ingresar al laboratorio antes de **4 horas** a temperatura ambiente; de lo contrario, se debe centrifugar y separar el suero/plasma antes del envío.
- **Muestras Especiales:** Exámenes como el PSD (parasitológico) se envían al completar la serie de 3 muestras en el frasco a temperatura ambiente. El Test de Graham se envía tras recolectar las 5 láminas de días consecutivos.

3.3.4. Sistema de Triple Embalaje

Para el transporte de sustancias infecciosas o envíos hacia centros de referencia (como el ISP), se exige obligatoriamente el sistema de triple embalaje:

1. **Recipiente Primario:** El tubo o frasco que contiene la muestra, debidamente sellado y rotulado.
2. **Embalaje Secundario:** Un envase impermeable y duradero (bolsa plástica con cierre hermético) que protege el recipiente primario. Debe contener material absorbente suficiente para retener todo el líquido en caso de rotura.
3. **Embalaje Terciario (Exterior):** Una caja de transporte rígida y resistente que contiene el embalaje secundario y las unidades refrigerantes. Debe llevar las

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 50 de 76

etiquetas de **"Riesgo Biológico"** y la clasificación **"Materia Biológica, Categoría B, UN3373"**.

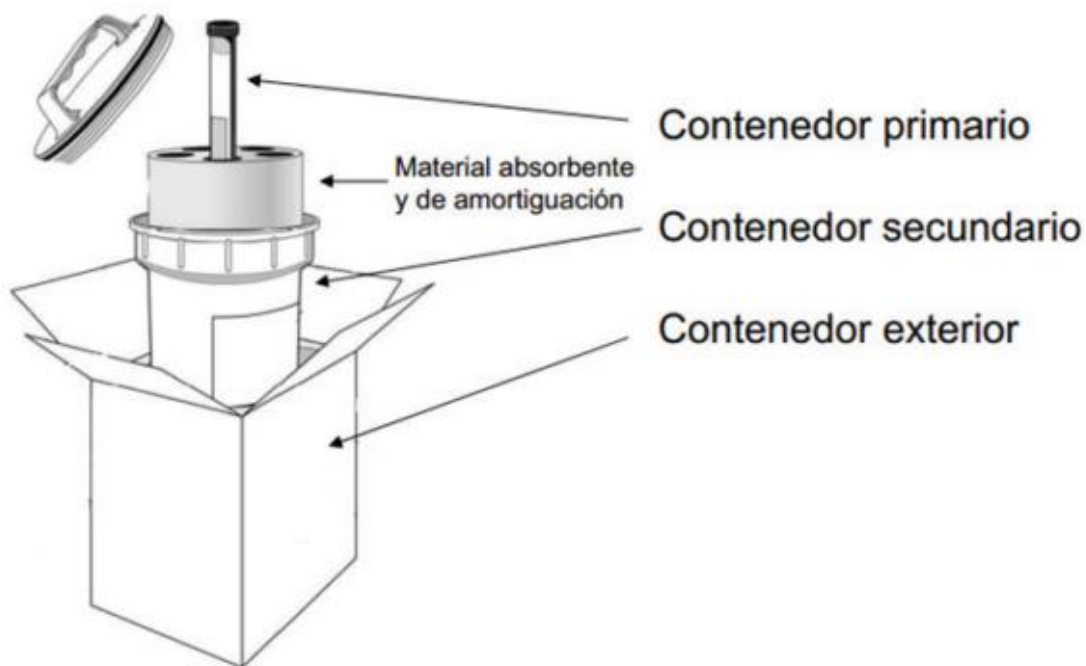


Imagen referencial de un sistema de triple embalaje.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 51 de 76



Imagen referencial de envío de muestras al Instituto de Salud Pública

3.3.5. Documentación y Trazabilidad

Las solicitudes de exámenes deben transportarse **fuera del contenedor de muestras** o dentro de una bolsa hermética independiente para evitar que se manchen o destruyan en caso de derrames. Se recomienda el uso de planillas o cuadernos de envío que deben ser firmados por el personal de recepción del laboratorio para garantizar la trazabilidad.

4. Gestión de calidad y control

4.1. Criterios de Aceptación y Rechazo de muestras.

Para asegurar la calidad de los resultados y la seguridad del paciente, es fundamental establecer **criterios de rechazo de muestras** claros y estandarizados. El incumplimiento de estos requisitos en la etapa preanalítica invalida el

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 52 de 76

procesamiento, ya que una muestra inadecuada no puede representar el estado clínico real del paciente. A continuación, se detallan los criterios de rechazo categorizados para su integración en las distintas tomas de muestras dependientes del laboratorio:

1. Criterios Relacionados con la Solicitud o Formulario	
Datos del paciente incompletos o erróneos:	Falta de nombre completo o RUN, o discordancia entre el nombre escrito y la base de datos.
Datos del médico o profesional incompletos:	Falta de nombre, RUN o firma del profesional solicitante.
Ilegibilidad de la orden:	Solicitudes con letra incomprensible tanto en datos del paciente como en los exámenes solicitados.
Discordancia de datos:	Cuando los datos demográficos en la solicitud no coinciden con los del rótulo del tubo o contenedor.
Falta de documentación obligatoria:	Para exámenes específicos como el VIH, se rechazará si no adjunta el consentimiento informado debidamente firmado o si no consigna la realización de la consejería.
Omisión de datos clínicos críticos:	Falta de diuresis en orina de 24 horas, o falta de fecha y hora de la última dosis en niveles plasmáticos de drogas.
2. Criterios Relacionados con la Muestra	
Sin muestra:	Sin muestra para lo solicitado en la orden de examen. Ej: Urocultivo sin muestra de orina.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 53 de 76

Muestra mal rotulada o sin rótulo:	Tubos sin identificación, con datos incompletos o con doble rotulación.
Muestra hemolizada:	Ruptura de glóbulos rojos que libera hemoglobina al plasma, alterando analitos como potasio o sodio.
Muestra coagulada:	Presencia de coágulos o microcoágulos de fibrina en tubos que contienen anticoagulante (tapa lila, celeste o verde).
Muestra escasa o bajo nivel:	Volumen insuficiente que altera la proporción crítica entre sangre y anticoagulante, especialmente en pruebas de coagulación (tubo tapa celeste).
Muestra sobre el nivel:	Llenado por encima de la marca, lo que puede anular el efecto del anticoagulante y favorecer la coagulación.
Muestra lipémica:	Turbidez excesiva por grasas que interfiere con las mediciones ópticas del laboratorio.
Muestra icterica:	Color amarillento intenso por bilirrubina que interfiere con las mediciones ópticas del laboratorio.
Muestra contaminada:	Por ejemplo, muestras de orina con deposiciones o flujo menstrual, o muestras respiratorias (esputo) que son predominantemente saliva.
3. Criterios Relacionados con el Contenedor y Material	
Contenedor inadecuado:	Uso de un tubo o frasco que no corresponde al examen solicitado (ej. tomar un hemograma en un tubo de tapa roja).
Material no estéril o vencido:	Uso de recipientes caducados o no estériles para exámenes microbiológicos.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 54 de 76

Pérdida de integridad de contenedor:	Tubos quebrados, mal tapados o con filtraciones.
4. Criterios Relacionados con el Transporte	
Pérdida de la cadena de frío:	Muestras que requieren refrigeración y llegan a temperatura ambiente.
Exposición a la luz:	Exámenes fotolábiles (como vitamina B12) transportados sin protección de la luz.
Demora en el envío:	Muestras recibidas fuera del tiempo máximo permitido desde su recolección.

Nota importante: En caso de rechazo, el laboratorio debe registrar el motivo en el sistema informático y dar aviso inmediato al servicio de origen para coordinar la toma de una nueva muestra y no retrasar el diagnóstico del paciente.

VII. INDICADOR DE RECHAZOS.

Nombre del indicador	Porcentaje de exámenes rechazados en el Laboratorio Clínico provenientes de cada toma de muestra interna y externa.
Descripción	Este indicador evalúa el cumplimiento de los criterios de calidad de las muestras recepcionadas y tomadas en el Laboratorio Clínico. Estos criterios se basan en lo indicado en el apartado de rechazos, quedando registro de las causas de rechazos en el SIL.
Tipo de indicador	Indicador de resultado

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 55 de 76

Numerador	Número de exámenes rechazados en el Laboratorio Clínico de “X” procedencia del mes “X”	X 100
Denominador	Número total de exámenes recibidos en el Laboratorio Clínico de “X” procedencia del mes “X”	
Fuente de datos	Fuente primaria: Numerador: Se obtiene del número de exámenes rechazados desde el sistema informático del Laboratorio Clínico. Denominador: Se obtiene del número de exámenes recepcionados desde el sistema informático del Laboratorio Clínico. Fuente secundaria: Informa mensual del indicador de rechazos de exámenes. (véase “Anexo 6. Tablas de registro indicador de rechazo”).	
Periodicidad	Evaluación mensual	
Umbral de cumplimiento	≤ 5 %	
Metodología de la medición	Los datos necesarios para elaborar el informe correspondiente a cada punto de verificación, son obtenidos desde el sistema informático del laboratorio. Se evaluará la totalidad de las muestras entregadas a la Unidad de Laboratorio de CESFAM.	
Responsable	Encargado de Calidad del Laboratorio Clínico	

Nota: El registro de los rechazos se llevará dentro una tabla (Google sheets: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EwJvD5EU8Ob8n4uqprHVkGR6PNZgDk6yREmOvEmquL4/edit?gid=82255218#gid=82255218>) llamada **“Indicador de Rechazo de Laboratorio”** y compartida por laboratorio, (véase **“Anexo 6. Tablas de registro**

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 56 de 76

indicador de rechazo”). En ésta se podrán ver los datos de registro individual, además del valor porcentual del indicador obtenido mes a mes y separado por procedencia (Total, Toma de muestra CESFAM, Posta Calleuque, Posta Población, Posta Los Cardos y Estacion médico rural Rinconada Molineros).

VIII. DISTRIBUCION

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario.
- Unidad Laboratorio Clínico CESFAM.
- Jefas de Sector Urbano y Rural.
- Postas de Salud Rurales Población, Los Cardos, Calleuque, EMR Rinconada Molineros.
- Unidades clínicas CESFAM y Postas.

IX. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / BIBLIOGRAFÍA:

- Decreto Supremo N° 20, Reglamento de Laboratorios Clínicos (Chile)
- Manual del estándar general de acreditación para prestadores institucionales de atención cerrada / abierta, ámbito APL.
- Instructivo para evaluación del Manual estándar acreditación Laboratorios Clínicos, ISP Chile [Instituto de Salud Pública de Chile](#)
- Protocolos de transporte de sustancias infecciosas (ISP)

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 57 de 76

X. AUTORES

- T.M Pía Gálvez Leyton, Director Técnico Laboratorio Clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- T.M Juan Contreras Sandoval, Encargado de Calidad Laboratorio Clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

XI. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambios	Fecha de cambios	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

XII. ANEXOS.

Anexo 1. Tiempo de respuesta de exámenes

Categoría / Examen	Tiempo de respuesta
Bioquímica Sangre	
Glicemia, Ácido Úrico, Creatinina, Urea, Electrolitos, Albumina, Bilirrubina directa, indirecta y total, Calcio, Colesterol total, LDL, VLDL y HDL, ALP, Fósforo, GGT, Glicemia, GOT, GPT, LDH, Proteínas totales, PTGO y Triglicéridos.	2 días hábiles
Perfil Bioquímico	2 días hábiles
Perfil Hepático	7 días hábiles
Perfil Lipídico	2 días hábiles
Hemoglobina Glicosilada	7 días hábiles

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 58 de 76

Hematología y Coagulación

Hemograma y Perfil hematológico	2 días hábiles
VHS (Velocidad de Sedimentación)	2 días hábiles
Tiempo de Protrombina (TP) / TTPK	7 días hábiles
Grupo sanguíneo	7 días hábiles
Test de Coombs directo e indirecto	7 días hábiles

Hormonas, Serología y Marcadores

TSH, T4 Libre, T3	7 días hábiles
Factor Reumatoideo	2 días hábiles
Progesterona, Prolactina, Estradiol, Cortisol (HRR)	7 días hábiles
Proteína C reactiva (PCR)	1 día hábil
PSA Total	7 días hábiles
Hepatitis B (HBsAC)	7 días hábiles
HIV ELISA	7 días hábiles
Chagas	7 días hábiles
RPR	2 días hábiles
VDRL	7 días hábiles
Test de embarazo	2 días hábiles

Orina

Orina completa, sedimento urinario	2 días hábiles
Microalbuminuria y RAC	2 días hábiles

Microbiología, TBC y Parasitología

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 59 de 76

Baciloscopía (TBC) y Pruebas Moleculares	7 días hábiles
Hemorragia oculta en deposición	2 días hábiles
Urocultivo	48 a 72 horas
Estreptococo grupo B	7 días hábiles
Coproparasitológico seriado de deposiciones	7 días hábiles
Test de Graham	7 días hábiles

Notas Importantes sobre los Tiempos

- **Punto de Inicio:** Los tiempos se cuentan desde que la muestra es **recepcionada e ingresada** en el Laboratorio Clínico.
- **Prioridad Urgente:** En casos específicos en los que se soliciten por un médico y solo para los parámetros como Perfil hematológico, PCR, Glicemia y otros previa evaluación con el solicitante. El tiempo de respuesta será dentro del día.
- **Resultados por Web:** Los profesionales pueden visualizar e imprimir los informes al día siguiente de ser validados a través de la plataforma web de Nobilis (Wiener).
- **Exámenes Derivados:** Muestras enviadas al ISP para confirmación (como Chagas o VIH) pueden demorar **más de 10 días hábiles** o hasta **3 semanas** y los derivados a otros centros hospitalarios como Santa Cruz o Rancagua de 7 a 14 días dependiendo de la disponibilidad de insumos de los centros.

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 60 de 76

Anexo 2: Instrucciones y preparación de pacientes

Anexo 2 a. Glicemia pre y post prandial

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 61 de 76



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL

Favor leer atentamente las instrucciones hasta el final.

INDICACIONES:

- El (la) paciente deberá presentarse el día de la citación con un ayuno de 8 a 12 horas, es decir que su última comida debe ser hasta las 20:00 horas del día anterior, después sólo puede tomar agua si lo requiere.
- No fumar ni consumir alcohol antes del examen.
- No realizar ejercicio físico previo al examen.
- Debe suspender medicamentos sólo si su médico lo indica.
- Debe traer la orden timbrada y su Carnet de Identidad.
- No se debe presentar al Laboratorio después de haber realizado un turno de noche.
- Traer desayuno indicado por profesional solicitante.

PROCEDIMIENTO

- Se le tomará una muestra de sangre inicial y luego deberá tomar su desayuno indicado por profesional que solicita el examen, una vez terminado avise inmediatamente a la persona que lo atendió.
- Desde el momento que tomó su desayuno deberá esperar 2 horas para tomarse una **segunda muestra** de sangre. **Durante la espera, debe permanecer en las dependencias del CESFAM**, pues debe estar en reposo durante las dos horas que dura el examen y durante ese período no debe ingerir ningún alimento ni líquido, tampoco debe fumar.
- Si siente cualquier malestar avise inmediatamente al personal de la Toma de Muestra

RECOMENDACIONES:

- * Se debe respetar las instrucciones, día de citación y horario, de lo contrario se deberá dar hora nuevamente.
- * Asegúrese de disponer del tiempo necesario para realizar este examen.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 62 de 76

Anexo 2 b. Prueba de tolerancia a la glucosa oral (P.T.G.O)



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono:72-2861053

PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (P.T.G.O)

Favor leer atentamente las instrucciones hasta el final.

INDICACIONES:

- El (la) paciente deberá presentarse el día de la citación con un ayuno de 8 a 12 horas, es decir que su última comida debe ser hasta las 20:00 horas del día anterior, después sólo puede tomar agua si lo requiere.
- No fumar ni consumir alcohol antes del examen.
- No realizar ejercicio físico previo al examen.
- Debe suspender medicamentos sólo si su médico lo indica.
- Debe traer la orden timbrada y su Carnet de Identidad.
- No se debe presentar al Laboratorio después de haber realizado un turno de noche.

PROCEDIMIENTO

- Se le tomará una muestra de sangre inicial y luego deberá tomar una solución de glucosa administrada por personal de Toma de Muestra. Una vez terminada la glucosa, avise inmediatamente a la persona que lo atendió.
- Desde el momento que tomó la sobrecarga de glucosa deberá esperar 2 horas para tomarse una **segunda muestra** de sangre. Durante la espera, debe permanecer en las dependencias del CESFAM, pues debe estar en reposo durante las dos horas que dura el examen y durante ese período no debe ingerir ningún alimento ni líquido, tampoco debe fumar.
- Si siente cualquier malestar avise a personal de la Toma de Muestra
- Si vomita la ingesta de glucosa debe avisar inmediatamente al laboratorio, pues se debe suspender el examen.

RECOMENDACIONES:

- * Se debe respetar las instrucciones, día de citación y horario, de lo contrario se deberá dar hora nuevamente.
- * Asegúrese de disponer del tiempo necesario para realizar este examen.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 63 de 76

Anexo 2 c. Exámenes de sangre en general

FECHA _____
HORA: 08:00 A 9:30



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

TOMA DE MUESTRA EXÁMENES DE SANGRE

Sr (a) Paciente:

Se le ha indicado un examen que requiere de una muestra de sangre, el (los) resultado (s) le permitirá a su médico tratante tomar las decisiones terapéuticas apropiadas para su estado de salud. Este instructivo es aplicable a los siguientes exámenes: Química Sanguínea, Perfil lipídico, Pruebas Hepáticas, Hemograma y Velocidad de Eritrosedimentación (VHS). Antes de realizar la toma de muestra, deberá leer atentamente las instrucciones hasta el final, para que el resultado del análisis solicitado por su médico tratante, sea de óptima calidad.

Indicaciones

- Estos exámenes necesitan ayuno de 8 a 12 horas, esto quiere decir, que su última comida debe ser hasta las 20:00 horas del día anterior. (Después de las 20 horas solo puede tomar agua si lo requiere).
- Evitar el consumo de grasas (cerdo, cecinas, frituras, mantequilla, lácteos).
- Respete las 12 horas sin fumar
- No consumir bebidas, no beber alcohol, té, café, jugos, dulces, leche, o cualquier comestible desde ese momento en adelante hasta después de la toma de muestra.
- No realizar ejercicio físico previo al examen.
- **Debe traer la orden timbrada y su Carnet de Identidad**

Procedimiento para la Recolección de la (s) Muestra (s):

- Este examen es realizado en la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio o en el Centro de Salud donde se atiende.
- **NOTA: SE RUEGA A LOS PACIENTES RESPETAR LAS INSTRUCCIONES, LA HORA Y FECHA DE CITACIÓN DE LO CONTRARIO SE DEBERÁ DAR HORA NUEVAMENTE.**

Traslado de las Muestras:

Según las especificaciones técnicas de cada examen

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 64 de 76

Anexo 2 d. Orina completa- sedimento urinario para hombres



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

ORINA COMPLETA- SEDIMENTO URINARIO PARA HOMBRES

En S.O.M.E del Centro de Salud Familiar Peralillo o Posta retire 1 frasco limpio y seco para la obtención de la muestra, antes de obtener la muestra se solicita **leer atentamente las instrucciones hasta el final.**

INDICACIONES:

- Realice un Aseo genital.
- Tomar (recolectar) la primera orina de la mañana (idealmente) segundo chorro.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

- Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado, sin tocar los bordes.
- Comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del baño.
- Luego haga el segundo chorro directamente en el frasco hasta la mitad.
- Tape el frasco y compruebe que ha quedado **bien cerrado**.



OBSERVACIONES

- El día y noche anterior a la recolección de la muestra de orina no debe tener relaciones sexuales.
- Informe al personal de la unidad de toma de muestras, en caso de estar ingiriendo medicamentos (antibióticos o analgésicos).

TRASLADO DE LA MUESTRA:

- Si se toma la muestra en el CESFAM, entréguelo a personal de laboratorio
- Si se toma la muestra en su domicilio u otro lugar, lleve el frasco tan pronto haya realizado la recolección a la Toma de Muestras del CESFAM o Posta, **antes de 2 horas** después de obtenida la muestra.
- Si el tiempo de traslado es mayor a 2 horas introduzca el frasco con la muestra en una bolsa plástica y amárrela. Luego, coloque esto en otra bolsa que contenga hielo (o si dispone de una bolsa Gel pack utilícela en reemplazo del hielo común) y amarre la bolsa.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 65 de 76

Anexo 2 e. Orina completa- sedimento urinario para mujeres



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

ORINA COMPLETA- SEDIMENTO URINARIO PARA MUJERES

En S.O.M.E del Centro de Salud Familiar Peralillo retire 1 frasco limpio y seco para la obtención de la muestra, antes de obtener la muestra se solicita **leer atentamente las instrucciones hasta el final.**

INDICACIONES:

- Tomar (recolectar) la primera orina de la mañana (idealmente) segundo chorro.
- **Realice un Aseo genital.** Punto importante en la calidad y resultado del examen.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

- Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado, sin tocar los bordes.
- Comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del baño.
- Luego haga el segundo chorro directamente en el frasco hasta la mitad.
- Tape el frasco y compruebe que ha quedado **bien cerrado.**



OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

- Colóquese un Tapón vaginal, si está menstruando; o una mota de algodón haciendo taponamiento vaginal, de este modo impide la contaminación de la muestra.
- El día y noche anterior a la recolección de la muestra de orina no debe tener relaciones sexuales.
- Informe al personal de la unidad de toma de muestras, en caso de estar ingiriendo medicamentos (antibióticos o analgésicos).

TRASLADO DE LA MUESTRA:

- Si se toma la muestra en la Toma de Muestras, entréguelo a la persona que lo atendió.
- Si se toma la muestra en su domicilio u otro lugar, lleve el frasco tan pronto haya realizado la recolección a la Toma de Muestras en el CESFAM o Posta, **antes de 2 horas** después de obtenida la muestra.
- Si el tiempo de traslado es mayor a 2 horas introduzca el frasco con la muestra en una bolsa plástica y amárrela. Luego, coloque esto en otra bolsa que contenga hielo (o si dispone de una bolsa Gel pack utilícela en reemplazo del hielo común) y amarre la bolsa

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 66 de 76

Anexo 2 f. Urocultivo y antibiograma



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA

Favor leer atentamente las instrucciones hasta el final.

INDICACIONES

- Retire el material en S.O.M.E
- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos
- Tomar la muestra idealmente al despertar (la primera orina de la mañana).
- El día y noche anterior a la recolección de la muestra de orina no debe tener relaciones sexuales.
- Si la muestra se toma durante el día tener una retención urinaria de al menos 4 horas

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA (S) MUESTRA(S):

- Lave cuidadosamente sus manos antes de recolectar la muestra.
- Realice el aseo genital

Mujer: separar cuidadosamente los labios mayores y realizar un aseo prolijo utilizando una tórula de algodón con jabón y luego dos tórulas empapadas en agua, deslizándolas de adelante hacia atrás una sola vez.

Hombre: deslice el prepucio (piel que cubre el pene) hacia atrás y realice un aseo minucioso del glande con una tórula jabonosa y luego enjuague con dos tórulas empapadas en agua usándolas una a la vez.

- Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado, sin tocar los bordes.
- Si es mujer, separe los labios mayores (genitales externos) con una de sus manos y manténgalos así durante todo el procedimiento de recolección de la muestra. Si es hombre, mantenga retraído el prepucio durante todo el procedimiento.
- Comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del baño.
- Luego, continúe orinando (segundo chorro) directamente en el frasco llenándolo hasta aproximadamente la mitad de su capacidad.
- Tape cuidadosamente el frasco y compruebe que quedó bien cerrado.
- Rotular bien el frasco con el nombre, los dos apellidos y Rut del paciente.
- Mantenga la muestra refrigerada.

TRASLADO DE LA MUESTRA:

- Si se toma la muestra en la Toma de Muestras, entréguelo a la persona que lo atendió.
- Si se toma la muestras en su domicilio u otro lugar, lleve el frasco tan pronto haya realizado la recolección a Toma de Muestras del CESFAM, Posta más cercana o al Laboratorio Clínico, antes de 2 horas después de obtenida la muestra.
- Si el tiempo de traslado es mayor a 2 horas ponga el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 67 de 76

Anexo 2 g. Orina de 24 horas



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS

INDICACIONES

- No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual.
- No mezclar la orina con papel higiénico o deposición.
- Si el examen que su médico le ha solicitado se llama "Proteinuria", recuerde que usted NO DEBE realizar ejercicios violentos durante el periodo de recolección de su muestra
- El recipiente adecuado para la recolección de su orina, debe ser una o más botellas de 2 a 3 litros (preferentemente de agua mineral) limpio y seco.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA (S) MUESTRA(S):

- El día previo al examen, a una hora determinada, de preferencia al levantarse, debe vaciar la vejiga orinando a fondo y botar esa orina. Escriba la hora en que ello ocurrió.
- Desde este momento en adelante, Usted debe juntar **TODA** la orina de cada micción durante las 24 horas siguientes. La última micción la debe hacer a la misma hora en que comenzó la recolección y ésta se añade a la recolectada
- **Por ejemplo:** si usted vació su vejiga a las 8:00 AM, eliminando la orina, debe orinar nuevamente a las 8:00 AM del día siguiente.
- **TODA** la orina recolectada durante el periodo completo debe guardarse **refrigerada**.
- Rotular embace con el nombre, los dos apellidos y Rut del paciente.

OBSERVACIONES:

- Para realizarse este examen debe solicitar hora en el CESFAM, el día citado debe acudir
- Hay exámenes de orina de 24 horas como el Clearance que va asociado a una muestra de sangre que deben ser tomada el mismo día que trae la muestra de orina.

TRASLADO DE LA MUESTRA:

- Debe llevar **TODA** la orina recolectada ANTES DE DOS HORAS a la Unidad de Toma de Muestras del CESFAM o Posta donde se atiende e informar la hora de inicio y término de su recolección.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado. |

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 68 de 76

Anexo 2 h. Parasitológico seriado de deposiciones (P.S.D.)



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES (P.S.D)

Este examen sirve para detectar parasitosis intestinales. Antes de realizar la toma de muestra, deberá leer atentamente las instrucciones hasta el final, para que el resultado del análisis solicitado por su médico tratante, sea de óptima calidad.

Indicaciones:

- Retire el material en S.O.M.E.
- Asegúrese de revisar todo el material antes de iniciar el procedimiento de recolección. El frasco debe poseer un líquido transparente o blanquecino y tener la espátula para la toma de muestra.
- Evite el uso de laxantes previo a la realización del examen.
- No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al examen

Procedimiento para la Recolección de la (s) Muestra (s):

- Defecar en un recipiente limpio y seco, cuidando que **NO** se mezcle con la orina
- Recolectar una muestra del tamaño de una almendra, empleando espátula del frasco.
- Si la muestra es líquida tomar la cantidad similar a una cucharada.
- Mezcle suavemente con el líquido sin derramar, mantenga ambos a temperatura ambiente, no exponer al sol.
- Repita el procedimiento día por medio hasta obtener 3 muestras.
- Si la muestra contiene mucus o sangre se recomienda tomar de esa zona.
- En caso de encontrar algún elemento blanquecino (gusano) enviar en otro frasco adicional que sólo contenga agua corriente.
- Rotular muestra con el nombre, los dos apellidos y Rut del paciente.

No ingerir el contenido de los frascos, ya que el líquido es un fijador TÓXICO. Mantener alejado de los niños.

Traslado de las Muestras:

- La muestra debe ser trasladada tan pronto haya realizado la recolección a la Unidad de Toma de Muestras del CESFAM o Posta de Salud donde se atiende.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS		Código:	APL 1.2
	LABORATORIO CLINICO		Fecha:	Julio 2026
			Versión:	1.0
			Vigencia:	Julio 2030
			Página:	Página 69 de 76

Anexo 2 i. Test de Graham



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

TEST DE GRAHAM

En S.O.M.E del CESFAM o Posta deberá solicitar el material necesario, que consiste en un sobre que contiene 5 láminas de vidrio las cuales tienen adherida una cinta engomada transparente (scotch), para la obtención de la muestra.

El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomarlas.

REQUISITOS:

- Evite la aplicación en la zona anal de ungüentos (cremas) y talco la noche anterior, previo a la realización del examen.
- La muestra debe ser recolectada a primera hora de la mañana.
- En lo posible la muestra debe ser recolectada por otra persona.
- No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al examen.

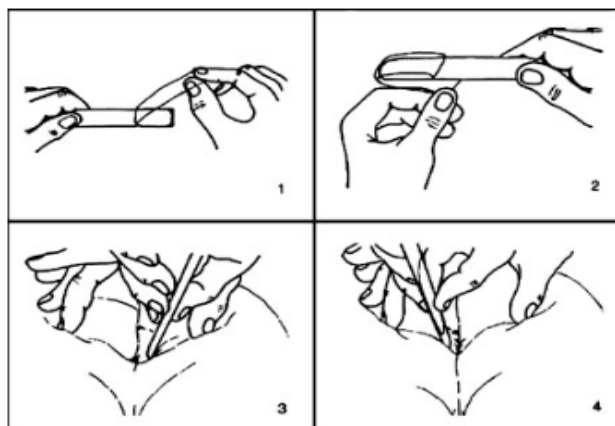
RECOLECCIÓN DE LA(S) MUESTRA(S):

- Asegúrese de revisar el material antes de comenzar la recolección de las muestras: cada caja o set contiene 5 láminas de vidrio.
- La muestra debe recolectarse a primera hora del día, antes del aseo matinal y antes de orinar y/o defecar.
- En el caso de que la zona anal ya se encuentre contaminada con deposición, no recolectar la muestra ese día. En el caso de niños pequeños que defecan generalmente a la misma hora, debe programarse la recolección para una hora antes al día siguiente.
- Tomar una placa de vidrio del envase, desde la parte de placas limpias, desprender la cinta engomada de la lámina (*dibujo 1 y 2*).
- Luego adherir y retirar varias veces la parte engomada en la zona anal y perianal (alrededor del ano), (*dibujo 3*).
- Volver a pegar la cinta engomada lo más estirada posible, evitando la formación de pliegues, sobre la lámina de vidrio (*dibujo 4*).
- Si encuentra algún gusano pequeño (2-3 mm) en la zona anal, péguelo al scotch y éste a la placa.
- Envolver la placa de vidrio con papel higiénico (o confort) colocándola en la bolsa de papel.
- Repita el procedimiento al día siguiente, utilizando una lámina de vidrio por día hasta completar 5 días.
- Rotular con el nombre, los dos apellidos y Rut del paciente.

Los huevos de *E. vermicularis* son muy contagiosos. Realice la toma de muestras extremando las medidas de higiene. Lávese cuidadosamente las manos una vez acabada la toma de muestras.

TRASLADO DE LA MUESTRA:

- Transporte cuidadosamente (evitando golpes y caídas, dado que el material es de vidrio) hacia la Toma de Muestras, tan pronto haya finalizado la recolección de todas las muestras.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.



NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 70 de 76

Anexo 2 j. Test de hemorragias ocultas



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

TEST DE HEMORRAGIAS OCULTAS

En S.O.M.E del CESFAM o Posta deberá solicitar material necesario. El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto **lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomarlas.**

Indicaciones:

- Este examen NO REQUIERE DIETA previa a su realización.
- Evite la contaminación de la muestra de deposición con orina
- Evite tomar la muestra de deposición durante el período menstrual. No recolectar las muestras hasta 3 días de terminado el período menstrual.
- No recolectar las muestras hasta 3 días de terminado el sangramiento por hemorroides o hematuria (sangre en orina)

Procedimiento para la Recolección de la (s) Muestra(s):

- Defecar en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con la orina
- Recolectar la muestra tomando una pequeña cantidad, empleando una espátula de madera.
- Tape el recipiente y cerciórese de que esté bien cerrado.
- Introduzca el recipiente con la muestra adentro de una bolsa plástica y en posición vertical, para evitar derrames.
- Anote el nombre, apellidos del paciente y la fecha en el recipiente de recolección.
- Una vez que haya recolectado entregar en Toma de Muestra o en Laboratorio, para su análisis.

Traslado de las Muestras:

- La muestra debe ser trasladada tan pronto haya realizado la recolección a la Unidad de Toma de Muestras del CESFAM o Posta de Salud donde se atiende.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.
- NO REFRIGERE.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 71 de 76

Anexo 2 k. Muestra de esputo (baciloscopia – TBC)



CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Peralillo
LABORATORIO CLÍNICO
Fono: 72-2861053

INDICACIONES TOMA DE MUESTRA DE DESGARRO (PARA BACILOSCOPÍA)

En S.O.M.E del CESFAM o Posta deberá solicitar material necesario. El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto **lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomarlas.**

Indicaciones:

- Este examen NO REQUIERE DIETA previa a su realización.
- No lave sus dientes con pasta de dientes.
- Sólo enjuague su boca con agua de la llave, elimine este enjuague en el lavamanos.
- Se toma en la mañana antes de desayunar en un lugar ventilado.

Procedimiento para la Recolección de la (s) Muestra(s):

- Toser y obtener 2 a 3 desgarros en el envase proporcionado.
- Tape el recipiente y cerciórese de que esté bien cerrado.
- Terminada la toma de muestra lave sus manos.
- Anote el nombre, apellidos del paciente y la fecha en el recipiente de recolección.
- Introduzca el recipiente con la muestra adentro de una bolsa plástica y en posición vertical, para evitar derrames.
- Una vez que haya recolectado entregar en Toma de Muestra o en Laboratorio, para su análisis.

Traslado de las Muestras:

- La muestra debe ser trasladada tan pronto haya realizado la recolección a la Unidad de Toma de Muestras del CESFAM o Posta de Salud donde se atiende.
- Si no puede trasladar la muestra el mismo día, conservar en refrigerador lejos del alcance de los niños.

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 72 de 76

Anexo 3: Resumen de tubos por batería

Resumen batería examen	Tubos				Total de tubos
	Celeste	Amarillo /Rojo	Lila	Gris	
Batería HTA	-	2	1	-	3
Batería DM	-	2	2	-	4
Pruebas hepáticas (solas)	1	1	-	-	2
Hormonas tiroideas (solas)	-	1	-	-	1
Batería HTA + P. Hepáticas	1	2	1	-	4
Batería DM + P. Hepáticas	1	2	2	-	5
Bat. HTA + P. Hep + hormonas	1	3	1	-	5
Bat. DM + P. Hep + hormonas	1	3	2	-	6

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 73 de 76

Anexo 4: Orden de estudio bacteriológico TBC

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 74 de 76



SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN BACTERIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA TUBERCULOSIS

NOMBRES	PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
RUN	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	SEXO	NACIONALIDAD
DOMICILIO			TELÉFONO	
ESTABLECIMIENTO		UNIDAD		

EXAMEN SOLICITADO PARA (Marque solo uno):

- ☐ Pesquisa de Caso Presuntivo de Tuberculosis (CPT) ☐ Control de tratamiento, mes N°: _____
☐ Persistencia de síntomas (CPT con examen previo negativo) ☐ Sospecha clínica (sin criterios de CPT)
☐ Sospecha de Micobacteria no tuberculosa (MNT)

IDENTIFIQUE GRUPOS VULNERABLES (Marque todos los que correspondan)

- ☐ Mayor de 65 años ☐ Alcohol/Drogas ☐ Inmunosupresión (cuál): _____
☐ Extranjero/a ☐ Pueblo indígena ☐ Otras poblaciones cerradas (especificar): _____
☐ Contacto de TB-Sensible ☐ Privado/a de libertad ☐ Otro grupo (especificar): _____
☐ Contacto de TB-Resistente ☐ Personal de salud
☐ PV VIH ☐ Trabajador/a expuesto/a a sílice
☐ Diabetes ☐ Situación de calle

Si marcó CPT, indique si presenta alguno(s) de los siguientes síntomas:

- ☐ Fiebre ☐ Sudoración nocturna
☐ Baja de peso ☐ Espujo con sangre (hemoptisis)

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO (Marque solo uno):

- ☐ Caso nuevo (sin tratamiento previo) ☐ Previamente tratado, pérdida de seguimiento
☐ Sospecha de fracaso de tratamiento ☐ Previamente tratado, recaída

SEÑALE EL TIPO DE MUESTRA (Marque solo uno):

- ☐ Espujo (2 muestras seriadas) Líquido: Tejido: Orina:
☐ Lavado broncoalveolar ☐ Cefalorraquídeo ☐ Ganglionar ☐ 1° muestra
☐ Aspirado bronquial ☐ Pleural ☐ Óseo ☐ 2° muestra
☐ Contenido gástrico ☐ Pleural ☐ 3° muestra
☐ Deposición
- ☐ Otros líquidos, tejidos o sangre (especificar): _____

NOMBRE Y RUN DEL SOLICITANTE	
FECHA DE SOLICITUD	
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA	
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA	

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 75 de 76

Anexo 5: Orden de VIH

SOLICITUD EXAMEN VIROLÓGICO VIH LABORATORIOS CLINICOS RED OHIGGINS													
ESTABLECIMIENTO		HOSPITAL/SERVICIO: CESFAM/POSTA:											
1. IDENTIFICACION													
NOMBRE (AMBOS NOMBRES, APELLIDO PATERNO Y MATERNO)													
RUT	TRANS	PUEBLO ORIGINARIO	MIGRANTE										
*Pasaporte:													
FECHA DE NACIMIENTO	Sexo:	FEMENINO	MASCULINO										
TELEFONO:	Previsión:	FONASA	ISAPRE										
NACIONALIDAD:			OTRO										
DIRECCION:													
<table border="1"> <tr> <td>Inicial Primer Nombre</td> <td>Inicial Primer Apellido</td> <td>Inicial Segundo Apellido</td> <td>Fecha Nacimiento dd / mm / aa</td> <td>Últimos 3 dígitos más verificador del Rut</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Inicial Primer Nombre	Inicial Primer Apellido	Inicial Segundo Apellido	Fecha Nacimiento dd / mm / aa	Últimos 3 dígitos más verificador del Rut								
Inicial Primer Nombre	Inicial Primer Apellido	Inicial Segundo Apellido	Fecha Nacimiento dd / mm / aa	Últimos 3 dígitos más verificador del Rut									
2- GRUPO DE PESQUISA													
Gestante Primer Examen	Personas con EMP	Fuente de Accidente											
Gestante Segundo Examen	Control salud ciclo vital	Cortopunzante											
Mujer en Trabajo Pre Parto o Parto	Donante de órganos y/o Tejidos	Accidente Cortopunzante personal de salud											
Control Comercio Sexual	Control TBC	Control por hepatitis B / hepatitis C											
Paciente en Diálisis	Violencia sexual	Morbilidad											
Consulta ITS	Pareja Serodiscordante	Consulta espontánea											
Control Fecundidad, Ginecológico, Climatérico	Pareja de gestante VIH positivo	Prueba Identidad (2da Muestra)											
Semanas Gestación	CODIGO SUR-VIH :												
3.- PROFESIONAL QUE SOLICITA (NOMBRE Y/O TIMBRE Y FIRMA):													
FECHA DE LA SOLICITUD: / /													
4.- MUESTRA TOMADA POR (NOMBRE Y/O TIMBRE Y FIRMA):													
FECHA: / / HORA: :													
5.-CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE O REPRESENTANTE:													
YO: RUT: - declaro haber comprendido este documento.													
Acepto la responsabilidad de retirar personalmente el resultado; en caso de no retirarlo en la fecha acordada, si el resultado es (+) acepto que se me contacte confidencialmente, según los procedimientos que me han informado (llamado telefónico, visita domiciliaria, carta certificada). Ante esto decido:													
SI, acepto realizarme el examen de detección del VIH		(nombre y firma consultante o representante legal)											
NO acepto realizarme el examen de detección del VIH		(nombre y firma consultante o representante legal)											
6.- ENTREGA DE RESULTADOS EXAMEN DETECCION DEL VIH													
Con fecha / / declaro que acepto la responsabilidad de retirar personalmente el resultado;													
En Caso de no retirarlo en la fecha acordada, si el resultado es (+) acepto que se me contacte confidencialmente, según los procedimientos que me han informado (llamado telefónico, visita domiciliaria, carta certificada).													
RECIBO CONFORME CON													
FECHA: / /													
FIRMA:													

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.2
		Fecha:	Julio 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 76 de 76

Anexo 6. Tablas de registro indicador de rechazo

MES	FECHA	N° ORDEN	RUT PACIENTE	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CRITERIO DE RECHAZO	PROCEDENCIA	OBSERVACIONES

Captura de pantalla referencial de la base de registros de rechazos

TOTAL CENTRO DE SALUD Y EXTERNOS				UMBRAL DE CUMPLIMIENTO	<= 5 %
AÑO	MES A EVALUAR	N° TOTAL DE RECHAZOS	N° TOTAL DE EXAMENES	VALOR INDICADOR %	
2026				#DIV/0!	
				#DIV/0!	
				#DIV/0!	
				#DIV/0!	
				#DIV/0!	

Captura de pantalla referencial de registro de indicador de rechazos